



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL

JÉSSICA RODRIGUEZ STREY

ESTAR EM EQUIPE E TRABALHAR EM EQUIPE:
COMPREENSÃO DA FORMAÇÃO, SIGNIFICADO, FACILITADORES, DESAFIOS E
ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA
SAÚDE DA FAMÍLIA

Porto Alegre

2026

JÉSSICA RODRIGUEZ STREY

ESTAR EM EQUIPE E TRABALHAR EM EQUIPE:
COMPREENSÃO DA FORMAÇÃO, SIGNIFICADO, FACILITADORES, DESAFIOS E
ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA
SAÚDE DA FAMÍLIA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ensino na Saúde.

Orientadora: Profa. Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

Linha de pesquisa: Processos de Ensino na Saúde

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Boa saúde e bem-estar/Educação de qualidade

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Rodriguez Strey, Jéssica

Estar em equipe e trabalhar em equipe: compreensão da formação, significado, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação na percepção de profissionais da saúde da família / Jéssica Rodriguez Strey. -- 2026.

118 f.

Orientadora: Ramona Fernanda Ceriotti Toassi.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Equipe de Assistência ao Paciente. 2. Relações Interprofissionais. 3. Estratégias de Saúde Nacionais. 4. Sistema Único de Saúde. 5. Pesquisa Qualitativa. I. Ceriotti Toassi, Ramona Fernanda, orient. II. Título.

JÉSSICA RODRIGUEZ STREY

ESTAR EM EQUIPE E TRABALHAR EM EQUIPE:
COMPREENSÃO DA FORMAÇÃO, SIGNIFICADO, FACILITADORES, DESAFIOS E
ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA
SAÚDE DA FAMÍLIA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ensino na Saúde.

Dissertação aprovada em: 25 de maio de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi (Orientadora) – Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde (PPG EnSau), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dr. Daniel Demétrio Faustino da Silva (Membro titular da banca) – Programa de Pós-graduação em Avaliação de Tecnologias para o SUS, Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Dra. Aline Blaya Martins (Membro titular da banca) – Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dra. Denise Bueno (Membro titular da banca) – Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde (PPG EnSau), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dra. Circe Maria Jandrey (Membro suplente externo da banca) –
Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Dr. Luiz Fernando Alvarenga (Membro suplente interno da banca) –
Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde (PPG EnSau), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

AGRADECIMENTOS

Aos meus guias, que me protegem e me orientam ao longo do caminho.

À minha família, por sempre acreditar em mim e me apoiar incondicionalmente. Em especial, ao meu marido, Maick, que nunca mediu esforços para ser meu suporte ao longo de toda a trajetória no mestrado, estando sempre presente e me incentivando a ser a minha melhor versão.

À minha querida orientadora, Professora Dra. Ramona, pela paciência e dedicação. Sou muito grata pelos ensinamentos e pelas experiências que me proporcionou ao longo desse caminho.

Aos meus colegas e amigos do mestrado, que tornaram essa jornada mais leve e cheia de significado.

Ao meu amigo Gustavo, que me incentivou a fazer o mestrado e me ensinou muito sobre empatia e sobre trabalhar com amor pelo que se faz.

Às minhas amigas, por serem meu ponto de apoio em todos os momentos. Em especial, à minha amiga Michelle, minha irmã científica, a quem sempre recorro quando tenho alguma dúvida ou angústia, e à minha amiga Raquel, que dividiu comigo os finais de semana da escrita das nossas dissertações.

À Camile, pela ajuda na transcrição das entrevistas, contribuição fundamental para a realização desta pesquisa.

Aos colegas da Estratégia Saúde da Família que aceitaram colaborar com esta pesquisa, tornando-a possível. A disponibilidade e a abertura de vocês foram essenciais.

Ao Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde, pelo suporte acadêmico e pelo ambiente de aprendizado que contribuiu imensamente para minha formação.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ser um espaço de formação pública e de qualidade, e pelas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento acadêmico e pessoal.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS	Agente Comunitário de Saúde
AHVN	Associação Hospitalar Vila Nova
APS	Atenção Primária à Saúde
ATLAS.ti	<i>Visual Qualitative Data Analysis</i>
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial
CEBES	Centro Brasileiro de Estudos da Saúde
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
COREQ	<i>Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research</i>
CRAS	Centro de Referência da Assistência Social
DCN	Diretrizes Curriculares Nacionais
EIP	Educação Interprofissional
eMulti	Equipes multiprofissionais na APS
EPS	Educação Permanente em Saúde
eSB	Equipe de Saúde Bucal
ESF	Estratégia Saúde da Família
ISCM	Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
OMS	Organização Mundial da Saúde
OS	Organizações Sociais
PAB	Piso da Atenção Básica
PACS	Programa de Agentes Comunitários de Saúde
PPG EnSau	Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde
PSF	Programa de Saúde da Família
PNAB	Política Nacional de Atenção Básica
PUCRS	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
RSDP	Rede de Saúde da Divina Providência
SUS	Sistema Único de Saúde
SMS	Secretaria Municipal de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
US	Unidade de Saúde
USP	Universidade de São Paulo
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Introdução: O trabalho colaborativo em equipe é uma ferramenta essencial para a promoção de cuidados integrados e resolutivos em saúde, sendo uma estratégia-chave para alcançar a integralidade no Sistema Único de Saúde (SUS). **Objetivo:** Compreender o significado do trabalho em equipe, identificando aspectos da formação, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação, na percepção de profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF). **Metodologia:** Trata-se de estudo de abordagem qualitativa fenomenológica, cujos participantes foram profissionais da ESF que atuavam na Coordenadoria Leste de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil (amostra intencional). O tamanho da amostra foi determinado pelo critério da saturação teórica aliado à análise da densidade do material textual produzido. Entrevistas individuais semiestruturadas, gravadas em áudio e transcritas na íntegra, foram realizadas. O material textual foi analisado com o auxílio do *software* ATLAS.ti, por meio da técnica de análise de conteúdo. **Resultados:** Participaram do estudo 13 profissionais (agentes comunitários de saúde, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, gerentes; médico e técnicos de Enfermagem), sendo nove mulheres, de 27 a 55 anos. A residência (n=5) e a especialização (n=5) foram as pós-graduações mais frequentes entre os participantes. O tempo de trabalho na ESF variou de três a 22 anos e na Unidade de Saúde em que atuavam de um mês a 13 anos. Durante a graduação, os profissionais relataram a ausência ou pouca vivência de aprendizado compartilhado e interativo com profissionais/estudantes de diferentes núcleos/cursos. A residência foi descrita como o espaço da formação que possibilitou o compartilhamento de saberes com outras profissões. O trabalho em equipe, com a atuação conjunta dos profissionais com seus conhecimentos específicos que se complementam, sem sobreposição ou hierarquização das profissões, foi entendido como aspecto central para a qualidade do cuidado na ESF. A comunicação efetiva entre os profissionais, com a garantia da fala, escuta, interação e compartilhamento de informações sobre os pacientes/usuários para a definição de planos de cuidado, foi apontada como essencial para a constituição do trabalho colaborativo. A comunicação apareceu como aliada na resolução de conflitos. Reuniões de equipe, visitas domiciliares e interconsultas foram identificadas como potentes para o trabalho colaborativo interprofissional. A eMulti foi percebida como um recurso para o fortalecimento do trabalho em equipe. Como desafios, os profissionais identificaram dificuldades de interação entre as profissões; falta de disponibilidade de determinados profissionais em atuar de forma integrada; tempo insuficiente das reuniões de equipe e a não garantia de participação de todos os profissionais; conflitos e ruídos na comunicação na equipe; alta demanda de atendimentos e sobrecarga de trabalho; equipes incompletas (afastamentos/férias) e rotatividade de trabalhadores. Os momentos de discussão, a ampliação do tempo de reuniões e o investimento em capacitações e atividades de educação permanente foram identificados como estratégias de qualificação das práticas interprofissionais. **Produto técnico:** A partir dos resultados do estudo, foi produzido relatório técnico conclusivo (Eixo 4: Serviços técnicos) sobre o trabalho em equipe na ESF direcionado a equipes gestoras e profissionais da ESF. **Considerações finais:** Este estudo contribuiu para a produção de evidências qualitativas sobre o significado do estar e trabalhar em equipe na ESF. Pesquisas futuras que incluam a representação de todas as profissões envolvidas no processo de trabalho da ESF, bem como de usuários-famílias, são recomendadas.

Palavras-chave: Equipe de Assistência ao Paciente. Relações Interprofissionais. Estratégias de Saúde Nacionais. Sistema Único de Saúde. Pesquisa Qualitativa.

ABSTRACT

Introduction: Collaborative teamwork is an essential tool for promoting integrated and effective health care, and a key strategy for achieving integrality within the SUS. **Objective:** To understand the meaning of teamwork, identifying aspects of professional training, facilitators, challenges, and qualification strategies, as perceived by professionals working in the Family Health Strategy (FHS). **Methodology:** This is a qualitative study with a phenomenological approach. Participants were FHS professionals working in Primary Health Care Units in the Eastern Health District of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, (intencional sample). Sample size was determined by the theoretical saturation criterion combined with analysis of the density of the textual material produced. Individual semi-structured interviews were conducted, audio-recorded and transcribed in full. The textual material was analyzed using ATLAS.ti software through content analysis technique. **Results:** Thirteen professionals participated (community health workers, dentists, nurses, managers, physician and nursing technicians), nine of whom were women, aged 27 to 55 years. Residency programs (n=5) and specialization courses (n=5) were the most frequent postgraduate qualifications. Length of work in the FHS ranged from three to 22 years, and time in the current unit ranged from one month to 13 years. During undergraduate training, professionals reported little or no experience of shared and interactive learning with professionals or students from different fields. Residency programs were described as the training space that enabled knowledge sharing across professions. Teamwork was understood as central to care quality, based on the complementary roles of professionals without overlap or hierarchical relationships. Effective communication among professionals, ensuring speaking, listening, interaction, and sharing of patients/users' information for care planning, was identified as essential for collaborative work. Communication also emerged as an ally in conflict resolution. Team meetings, home visits, and interconsultations were considered important spaces for interprofessional collaborative work. The multiprofessional support team (eMulti) was perceived as strengthening teamwork. Challenges included difficulties in interprofessional interaction, lack of willingness among some professionals to engage collaboratively, insufficient time for meetings, limited participation of all team members, communication barriers, high workload and demand, staff shortages, and workforce turnover. Strategies for improving teamwork included strengthening discussion spaces, increasing meeting time, and investing in training and continuing education initiatives. **Technical product:** Based on the study results, a conclusive technical report was produced (Axis 4: Technical Services) on teamwork in the FHS, aimed at management teams and FHS professionals. **Final considerations:** This study contributes to the production of qualitative evidence on the meaning of being and working in teams within the FHS. Future research including all professional categories involved in FHS work processes, as well as users and families, is recommended.

Keywords: Patient Care Team. Interprofessional Relations. National Health Strategies. Unified Health System. Qualitative Research.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	8
1 INTRODUÇÃO	10
2 OBJETIVOS	12
2.1 OBJETIVO GERAL	12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12
3 REFERENCIAL TEÓRICO	13
3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO SUS	13
3.2 TRABALHO EM EQUIPE NA APS	15
3.3 EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PRÁTICAS COLABORATIVAS	17
4 METODOLOGIA.....	23
4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO.....	23
4.2 LOCAL DO ESTUDO	23
4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO.....	24
4.4 PRODUÇÃO DE DADOS.....	25
4.5 ANÁLISE DE DADOS.....	26
4.6 ASPECTOS ÉTICOS.....	26
5 RESULTADOS	28
6 DISCUSSÃO.....	56
7 PRODUTO TÉCNICO	63
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
REFERÊNCIAS	67
ANEXO A – TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA	80
ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA, CEP UFRGS	81
ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA, CEP SMS DE PORTO ALEGRE	88
APÊNDICE A – CRITÉRIOS COREQ	94
APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA	97
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	99
APÊNDICE D – PRODUTO TÉCNICO	102

APRESENTAÇÃO

Formei-me como cirurgia-dentista em janeiro de 2017 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Desde a graduação, durante os estágios, comecei a me identificar com a Saúde Coletiva. Foi nesse período que percebi que queria trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na atenção primária.

Após a graduação, fiz Residência Integrada em Saúde Bucal com ênfase em Estomatologia, na Faculdade de Odontologia da UFRGS. Nesse período, tive a oportunidade de trabalhar e aprender com outros núcleos profissionais. Poder conviver com outros profissionais me possibilitou entender que diferentes pessoas enxergam/promovem o cuidado de formas diferentes, o que me trouxe bastante aprendizado sobre o trabalhar em equipe, por meio de discussões e planejamento de casos, mas também sobre vínculo, empatia e acolhimento.

Em 2020, iniciei minha atuação na Estratégia Saúde da Família (ESF) como profissional contratada pela Rede de Saúde da Divina Providência (RSDP), com vínculo celetista. Inicialmente, trabalhei na Coordenadoria Oeste de Porto Alegre, na Unidade de Saúde (US) Nossa Senhora de Belém, e, posteriormente, passei a atuar na Coordenadoria Leste, na US Vila Jardim, desde março de 2023.

Nesse período, também me tornei especialista em Saúde Pública pela UFRGS, o que reforçou ainda mais meu conhecimento e vínculo com o SUS. Ao longo da minha trajetória profissional, tive a oportunidade de atuar como preceptora de estudantes da graduação. Essa experiência foi muito significativa, pois me fez observar de forma mais crítica como a Odontologia, muitas vezes, fica deslocada do trabalho em equipe dentro da ESF, tanto no processo de formação quanto na prática de trabalho.

Quando optei por ingressar no mestrado, eu já percebia que não gostaria de focar especificamente na prática odontológica como objeto de estudo, mas sim, abordar um tema que contemplasse a complexidade das equipes e dos profissionais da ESF.

A partir dessas vivências, juntamente com a orientação da professora Dra. Ramona, surgiu o interesse em investigar o trabalho em equipe e estudar/compreender a interprofissionalidade (educação e trabalho), buscando compreender as dinâmicas, potencialidades e desafios presentes no cotidiano das equipes da ESF.

Nesse contexto, o presente estudo vinculado ao Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde (PPG EnSau) da UFRGS, trata do tema trabalho em equipe no contexto da Saúde da Família, local em que atuo e desenvolvo minha prática profissional,

como cirurgiã-dentista na equipe de saúde bucal. Elaborou-se um estudo de abordagem qualitativa que se propõe a compreender o significado do trabalho em equipe, identificando aspectos da formação, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação, na percepção de profissionais que atuam na ESF.

A Dissertação está organizada em oito capítulos. O capítulo 1 – Introdução, apresenta o tema, o contexto da pesquisa e o problema investigado. O capítulo 2 – Objetivos, explicita os objetivos geral e específicos do estudo. O capítulo 3 – Referencial teórico, aborda os principais conceitos e autores que sustentam a discussão. O capítulo 4 – Metodologia, descreve o delineamento do estudo, o cenário, os participantes, os procedimentos de produção e análise dos dados e os aspectos éticos. O capítulo 5 – Resultados, apresenta os achados da pesquisa. O capítulo 6 – Discussão, analisa os resultados à luz do referencial teórico e traz reflexões sobre as limitações do estudo e pesquisas futuras. O capítulo 7 – Produto técnico, descreve o produto desenvolvido a partir do estudo. Por fim, o capítulo 8 – Considerações finais, sistematiza os principais achados da pesquisa, contribuições e perspectivas de encaminhamentos/publicações.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Compreender o significado do trabalho em equipe, na percepção de profissionais que atuam equipes de ESF da Coordenadoria Leste do município de Porto Alegre.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar aspectos da formação relacionados ao trabalho em equipe na ESF.
- Identificar características do processo de trabalho em equipe na ESF, analisando facilitadores e desafios.
- Apresentar estratégias de qualificação do trabalho em equipe, a partir da percepção de profissionais que atuam na ESF.
- A partir dos resultados da pesquisa, elaborar relatório técnico conclusivo sobre o trabalho em equipe na ESF (produto técnico).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO SUS

A APS refere-se a um conjunto de práticas integrais voltadas para atender tanto necessidades individuais quanto coletivas, com o usuário-cidadão no centro do cuidado (Giovannella; Mendonça, 2012). Como parte essencial do SUS no Brasil, a APS constitui o primeiro nível de contato dos indivíduos com o sistema de saúde e se baseia em princípios como universalidade, integralidade, equidade e participação social. Para alcançar esses objetivos, a APS adota atributos como acessibilidade, integralidade, coordenação, continuidade e responsabilidade, atuando no contexto familiar e comunitário para promover cuidados de saúde contínuos e abrangentes (Starfield, 2002; Paim *et al.*, 2011).

A APS tem suas origens no início do século XX, com a publicação do Relatório Dawson de 1920 – elaborado pelo Ministério de Saúde do Reino Unido. Este relatório propôs a criação de uma rede de saúde organizada em três níveis de complexidade, sendo a atenção primária o primeiro nível. Esse conceito, sob a perspectiva de organização sistêmica regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, por nível de complexidade e sob uma base geográfica definida, foi a base para a reorganização dos serviços de saúde em muitos países (Starfield, 2002; Lavras, 2011).

A definição de APS foi consolidada em 1978, com a Declaração de Alma-Ata. Esta conferência internacional, realizada por organizações das Nações Unidas, destacou a necessidade de os governos desenvolverem políticas nacionais, estratégias e planos de ação voltados à implementação da APS como parte de um sistema nacional de saúde integral e em coordenação com outros setores para enfrentar os determinantes sociais e ambientais da saúde. A Declaração de Alma-Ata reafirmou o papel da APS como a principal estratégia para alcançar a ‘Saúde para Todos’ e reconheceu que a atenção primária deveria ser o primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde, sendo acessível e eficiente para atender às necessidades básicas de saúde de toda a população (Starfield, 2002; Giovannella *et al.*, 2019).

Na década de 1970, o Brasil vivenciou uma intensificação das contradições no setor da saúde, o que revelou uma grave crise sanitária em meio ao aumento das desigualdades na organização econômica e social do país (Paim, 2008). Nesse contexto, tornou-se evidente a necessidade urgente de democratizar a saúde e promover uma reforma social. No campo político e ideológico, o movimento pela reforma da saúde no Brasil defendia que a saúde não deveria ser reduzida a uma questão biológica a ser solucionada por serviços médicos, mas sim

abordada como uma questão social e política, exigindo uma resposta pública e coletiva (Paim *et al.*, 2011).

O movimento da Reforma Sanitária Brasileira, responsável por formular uma concepção ampla para a saúde e o próprio projeto do SUS, nasce com a criação do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES), em 1976, representando um marco na luta pela democratização da saúde no Brasil. Estudantes, profissionais e movimentos sociais uniram-se em um debate para reivindicar mudanças na saúde pública em um difícil momento histórico brasileiro que foi o período da ditadura militar (1964-1984) (Paim, 2010; Costa; Almeida; Gomes, 2020). A luta por um sistema público universal de saúde iniciou-se na década de 1970 e persistiu ao longo das décadas subsequentes, visando à implantação e à consolidação do SUS (Paim, 2010; Costa; Almeida; Gomes, 2020).

Em 1979, o CEBES apresentou um documento no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde na Câmara Federal, intitulado ‘A questão democrática na área da saúde’ no qual foi proposta a criação de um sistema único de saúde no Brasil (Costa; Almeida; Gomes, 2020). Essa ideia foi retomada e ampliada durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, onde a saúde foi reafirmada como um direito do cidadão. O evento estabeleceu os fundamentos do SUS e impulsionou o desenvolvimento de estratégias voltadas à coordenação, integração e transferência de recursos entre as esferas federal, estadual e municipal. Essas mudanças administrativas consolidaram as bases para as ações futuras do SUS (Paim *et al.*, 2011).

A conquista pelo direito à saúde no Brasil foi formalizada na Constituição Federal de 1988. Resultante da mobilização e pressão social, o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, garantiu o acesso universal aos serviços de saúde em todos os níveis de atenção e regiões do país, considerando as especificidades e necessidades da população (Paim, 2008; Costa; Almeida; Gomes, 2020).

Dando continuidade a esse movimento, foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde, constituída pela Lei nº 8.080/1990 (Brasil, 1990a) e Lei nº 8.142/1990 (Brasil, 1990b). A Lei nº 8.080 estabeleceu diretrizes para a descentralização político-administrativa do SUS, com ênfase na gestão, financiamento e regulamentação das condições para sua promoção, proteção e funcionamento. Por sua vez, a Lei nº 8.142 regulamentou a participação social no SUS e as transferências de recursos financeiros (Brasil, 1990a; Brasil, 1990b; Andrade; Pontes; Martins Junior, 2000). Nesse contexto, começaram a ser desenvolvidas ações e serviços em saúde com base na atenção primária. Essas iniciativas inspiraram a criação do Programa de Agentes

Comunitários de Saúde (PACS) e, posteriormente, do Programa de Saúde da Família (PSF), precursores da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (Pinto; Giovanella, 2018).

Desde sua criação em 1994, o PSF foi se tornando a principal estratégia para a ampliação do acesso de primeiro contato e de mudança do modelo assistencial. Pouco mais de dez anos depois, em 2006, através da Portaria nº GM/648, o Ministério da Saúde publicou a PNAB (Brasil, 2006), considerada marco histórico para a consolidação nacional e a expansão da ESF, visando a reorganização da atenção primária no Brasil (Conill, 2008; Pinto; Giovanella, 2018).

Em 2017, houve a revisão da PNAB (Brasil, 2017), sendo identificada como um marco de retrocesso e riscos para o modelo assistencial da ESF (Machado; Melo; Paula, 2019; Giovanella; Franco; Almeida, 2020). Entre as principais mudanças, a nova política permitiu a composição de equipes de Saúde da Família com apenas um Agente Comunitário de Saúde (ACS) e a criação de equipes de Atenção Primária (eAP) sem a obrigatoriedade deste profissional, o que compromete o pilar comunitário e as ações de promoção de saúde. Além disso, a PNAB (Brasil, 2017) possibilitou a contratação de profissionais com carga horária reduzida (mínimo de dez horas semanais), o que pode incentivar uma atuação focada na atenção curativa e no controle de riscos individuais, enfraquecendo atributos como a longitudinalidade e a coordenação do cuidado (Morosini; Fonseca; Lima, 2018). Essas alterações, inseridas em um contexto de reformas neoliberais, sinalizam um redirecionamento que ameaça os princípios de universalidade e equidade, favorecendo a fragmentação do sistema e a abertura para a privatização da atenção primária (Giovanella; Franco; Almeida, 2020; Ortega; Pele, 2023).

O novo modelo de financiamento da APS, o Programa Previne Brasil, foi instituído em 2019 (Brasil, 2019) pela introdução de pagamento por capitação ponderada. Este modelo substituiu o sistema anterior, baseado no Piso da Atenção Básica (PAB) fixo e variável, por uma lógica centrada no número de pessoas cadastradas nas equipes de saúde. Além da capitação ponderada, o novo financiamento também incluiu componentes baseados no desempenho das equipes e em incentivos para ações específicas de saúde (Giovanella; Franco; Almeida, 2020).

3.2 TRABALHO EM EQUIPE NA APS

A ESF estabelece como principal meta a oferta de uma atenção integral e contínua para a população (Brasil, 2017). Para alcançar esse objetivo, a PNAB reforça a necessidade de os profissionais atuarem de maneira interdisciplinar, integrando conhecimentos de diversas disciplinas e áreas de formação, buscando o trabalho interprofissional para promover o planejamento compartilhado dos cuidados em saúde e a integração das ações (Kanno *et al.*,

2023). Assim, o trabalho em equipe apresenta-se como uma estratégia para reorganizar os processos de trabalho e qualificar os serviços de saúde, considerando que os esforços individuais são insuficientes para responder à complexidade das necessidades em saúde (Frenk *et al.*, 2010; Garcia *et al.*, 2015; Peduzzi *et al.*, 2020; Frenk *et al.*, 2022).

O trabalho interprofissional busca a colaboração entre profissionais de diferentes áreas da saúde, pela articulação de distintos saberes com o objetivo de melhorar a prática clínica e os resultados de saúde. A integração interprofissional promove uma abordagem coordenada e eficiente do cuidado, com impacto positivo na qualidade dos serviços prestados, além de favorecer uma visão crítica sobre as suas práticas (D'Amour *et al.*, 2005; Reeves *et al.*, 2017; Souza; Ely; Toassi, 2022).

Para D'Amour *et al.* (2008), a colaboração ocorre quando profissionais de diferentes áreas atuam de forma conjunta na produção do cuidado, sem abrir mão de seus interesses e de um determinado nível de autonomia. Práticas colaborativas são estratégias fundamentais para otimizar recursos, qualificar o cuidado e o serviço, além de contribuir para a resiliência da força de trabalho. Nesse sentido, a colaboração também se mostra igualmente necessária para promover a equidade na saúde em direção a cuidados culturalmente seguros (Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2024).

Peduzzi (2001) diferencia modalidades de atuação das equipes, destacando que a simples justaposição de profissionais em um mesmo espaço caracteriza apenas uma equipe-agrupamento, marcada pela fragmentação das ações e pelo distanciamento entre os trabalhadores. Em contrapartida, a equipe-integração pressupõe a conexão efetiva das ações e interação dialógica, orientada pelos princípios da integralidade, equidade e universalidade do SUS.

Reeves *et al.* (2010) propõem um modelo teórico para compreensão do trabalho em equipe interprofissional estruturado em quatro domínios interdependentes: relacional, processual, organizacional e contextual. O domínio relacional abrange aspectos como relações de poder, socialização profissional, composição da equipe e definição de papéis, influenciando diretamente as interações entre os profissionais. O domínio processual refere-se às condições em que o trabalho ocorre, incluindo tempo, espaço, rotinas, uso de tecnologias e a complexidade das demandas assistenciais. Já o domínio organizacional diz respeito às características institucionais e ao suporte oferecido pelas organizações de saúde, como estrutura, gestão e cultura organizacional. Por fim, o domínio contextual envolve fatores mais amplos, como aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos que impactam o funcionamento das equipes. Esses domínios estão inter-relacionados e influenciam, de forma dinâmica, a produção do

trabalho em equipe, podendo tanto facilitar quanto dificultar a prática colaborativa interprofissional.

A literatura permite distinguir diferentes modalidades de prática interprofissional conforme o grau de integração e o tipo de tarefa executada. Segundo Reeves, Xyrichis e Zwarenstein (2018), o trabalho em equipe representa a forma mais intensa de atuação, caracterizada por uma identidade compartilhada, compartilhamento de valores, forte interdependência e responsabilidade comum, sendo indicado para lidar com tarefas complexas e imprevisíveis.

Em ensaio teórico sobre as três décadas da ESF, Oliveira *et al.* (2025) analisaram a trajetória do trabalho em equipe, evidenciando que, embora a atuação multiprofissional tenha gerado avanços significativos, como a redução da mortalidade infantil e das internações por condições sensíveis à atenção primária, sua consolidação ainda enfrenta desafios estruturais e relacionais. O estudo indicou uma persistente dualidade entre a ‘equipe-agrupamento’, caracterizada pela fragmentação e justaposição de ações uniprofissionais, e a ‘equipe-integração’, que se fundamenta na interação dialógica, na interdependência e no compartilhamento de objetivos comuns. Como principais barreiras, foram identificadas a colaboração interprofissional, a formação acadêmica insuficiente, a alta rotatividade de profissionais, a precarização dos vínculos laborais e a precariedade da infraestrutura física das unidades. Além disso, o estudo destacou que falhas na comunicação formal e o predomínio de relações assimétricas de poder, influenciadas pelo modelo biomédico hegemônico, comprometem a coordenação do cuidado. Diante desse cenário, os autores recomendaram o fortalecimento da governança, a implementação de políticas de educação permanente com foco na interprofissionalidade e a criação de espaços democráticos de diálogo para garantir a sustentabilidade das práticas colaborativas e a integralidade da atenção no SUS.

3.3 EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E PRÁTICAS COLABORATIVAS

O avanço tecnológico, a especialização e o aprimoramento das capacidades diagnósticas e terapêuticas trouxeram profundas transformações para o trabalho em saúde. Embora tenham impulsionado o progresso na identificação e tratamento de doenças, esses avanços também geraram uma fragmentação do saber, além de um enfoque reducionista e estratificado sobre os indivíduos. Essa fragmentação consolidou um modelo de atenção à saúde centrado em procedimentos diagnósticos e terapêuticos, reforçando a divisão de trabalho entre diferentes profissionais, o que constitui uma barreira significativa tanto para a transformação

do modelo assistencial quanto para a reorientação da formação dos trabalhadores de saúde (Costa, 2017; Mira *et al.*, 2022).

A Educação Interprofissional (EIP) tem sido promovida como uma estratégia essencial para aprimorar o trabalho em equipe e desenvolver competências colaborativas, desafiando a abordagem uniprofissional e disciplinar focada apenas nas competências específicas de cada área. O movimento a favor da EIP tem se expandido globalmente, com o objetivo de incentivar a aprendizagem colaborativa entre diferentes profissões da saúde, de modo a melhorar a qualidade do cuidado e dos serviços prestados (Organização Mundial da Saúde, 2010; Peduzzi *et al.*, 2013; Ely; Toassi, 2018; Freire Filho *et al.*, 2019; Souza; Ely; Toassi, 2022; Toassi *et al.*, 2026).

A EIP oferece um espaço contínuo de aprendizado, permitindo que os profissionais compartilhem conhecimentos e compreendam suas respectivas responsabilidades, promovendo uma interação significativa e integrada dentro das equipes de saúde (Organização Mundial da Saúde, 2010; Barr; Low, 2013; Ely; Toassi, 2018; Souza; Ely; Toassi, 2022; Toassi *et al.*, 2026). No entanto, a mera localização de profissionais de diferentes áreas em um mesmo serviço não assegura a colaboração, sendo necessário um esforço conjunto para formar profissionais capazes de respeitar a expertise alheia e estabelecer parcerias, conforme os princípios de universalidade, integralidade, equidade e participação social do SUS (Silva; Scapin; Batista, 2011; Peduzzi, 2017; Peduzzi; Agreli, 2018; Griggio *et al.*, 2020).

Nesse sentido, a integração ensino-serviço-comunidade tem sido destacada como estratégia fundamental para aproximar a formação das necessidades do SUS e fortalecer o trabalho em equipe, sendo recomendada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da área da saúde, que orientam a formação para atuação interprofissional, para o cuidado integral e para o trabalho em equipe nos diferentes níveis de atenção (Brasil, 2021; Prevedello; Góes; Cyrino, 2022; Brasil, 2025; Associação Brasileira de Educação Médica, 2026).

Lima *et al.* (2024) analisaram a presença da interprofissionalidade nas DCN de 14 cursos de graduação da área da saúde no Brasil e identificaram que, embora a maioria dos documentos faça referência ao trabalho em equipe, as menções explícitas ao trabalho interprofissional ainda são limitadas. Os resultados demonstraram que os cursos de Farmácia, Medicina, Psicologia, Odontologia e Terapia Ocupacional apresentam referências mais diretas à atuação interprofissional, sendo que os cursos de Medicina e Odontologia se destacam por incorporar essa perspectiva também nas competências profissionais e no conteúdo curricular. Em relação às competências para a formação, verificou-se que a maior parte das DCN valoriza habilidades como comunicação, atenção à saúde, tomada de decisões e capacidade de liderança

no trabalho em equipe multiprofissional. Quanto à formação para o SUS, observou-se que seus princípios e diretrizes estão presentes na maioria dos cursos, com maior ênfase nas DCN de Medicina e Odontologia, que articulam explicitamente a formação profissional aos princípios da universalidade, integralidade e equidade. No que se refere ao conteúdo curricular, o estudo mostrou a predominância de uma organização centrada em conhecimentos técnicos e biomédicos, embora a maioria das DCN incluam conteúdos interdisciplinares e experiências práticas que podem favorecer o desenvolvimento de práticas colaborativas e interprofissionais.

Conforme Barr e Low (2013, p. 3), “a EIP ocorre quando dois ou mais profissionais aprendem com os outros, entre si e sobre os outros para aprimorar a colaboração e qualidade dos cuidados e serviços”. Para Reeves *et al.* (2013), a EIP ocorre quando os membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou a saúde/bem-estar dos usuários. No Brasil, o debate sobre a interprofissionalidade e o trabalho em equipe remonta à construção do SUS, que, desde sua fundação, foi baseado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade. A EIP se torna, assim, uma estratégia relevante para a concretização desses princípios, promovendo a integralidade das ações em saúde e respondendo às necessidades complexas da população (Peduzzi, 2016; Costa, 2017; Ferla; Falcão; Macedo, 2019). À medida que o SUS se expandiu, a diversificação de pontos de atenção e de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde fortaleceu a relevância da EIP. As necessidades de saúde, cada vez mais dinâmicas e complexas, desafiam os profissionais da APS, exigindo práticas de cuidado colaborativas e integradas, centradas nas necessidades dos indivíduos e capazes de fornecer um atendimento seguro, eficaz e de qualidade (Organização Mundial da Saúde, 2010; Reeves, 2016; Costa, 2017).

Barr (1998) propôs três tipos de competências essenciais no contexto da EIP: competências específicas, comuns e colaborativas. As competências específicas preservam as identidades profissionais, enquanto as comuns refletem a interseção entre diferentes profissões, e as colaborativas otimizam as relações no trabalho em equipe, facilitando a complementação das ações de saúde (Barr, 1998; Costa, 2017).

Em 2010, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o ‘Marco para Ação de Educação Interprofissional e Práticas Colaborativas’ com o objetivo de

contextualizar o sistema de saúde existente, se comprometer em implementar os princípios da educação interprofissional e da prática colaborativa, e de promover os benefícios da colaboração interprofissional com seus parceiros regionais, educadores e profissionais de saúde (Organização Mundial da Saúde, 2010, p. 11).

O Canadian Interprofessional Health Collaborative – CIHC (2010) estabeleceu seis domínios de competências colaborativas: (a) clarificação dos papéis profissionais; (b) atenção centrada no paciente-família-comunidade; (c) dinâmica de funcionamento em equipe; (d) liderança colaborativa; (e) comunicação interprofissional; (f) resolução de conflitos interprofissionais. Tais domínios são compreendidos como elementos essenciais para a produção de qualidade na atenção à saúde. Na versão atualizada (Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2024), o CIHC manteve a estrutura de seis domínios interdependentes, porém, com uma abordagem ampliada e centrada nas relações. Os domínios passam a ser: (a) cuidado/serviços centrados nas relações interpessoais e interprofissionais; (b) comunicação interprofissional; (c) compreensão dos papéis profissionais e negociação; (d) funcionamento da equipe; (e) resolução de conflitos; e (f) liderança colaborativa. Além disso, o modelo enfatizou que esses domínios são influenciados por fatores como equidade, inclusão e acesso, bem como pela complexidade dos contextos de cuidado e pelos cenários de atuação, reforçando a necessidade de práticas colaborativas flexíveis e adaptadas às realidades atuais.

O objetivo central da EIP é transformar o processo de aprendizagem para aprimorar as práticas colaborativas, resultando em profissionais mais preparados para enfrentar os desafios da APS e prestar um cuidado mais integrado e seguro (Reeves, 2016; Costa, 2017; Peduzzi, 2017; Ely; Toassi, 2018). O sucesso da prática colaborativa está diretamente ligado à capacidade de as equipes lidarem com divergências e encontrarem pontos de convergência (Barr, 1998; Agreli; Peduzzi; Silva, 2016; Ely; Toassi, 2018; Souza; Ely; Toassi, 2022). Padilla (2019) reforça que a prática colaborativa aprimora a qualidade das atividades clínicas e os resultados em saúde, seja em hospitais ou unidades de atenção primária. Para que a EIP seja efetiva, é necessário um aprendizado interativo e intencional entre os profissionais, com enfoque na construção teórica e metodológica voltada à colaboração (Costa, 2017).

A EIP é recomendada como parte do desenvolvimento profissional contínuo, da formação e continuando ao longo da carreira. Adaptada ao estágio de aprendizado, a EIP é essencial para preparar os estudantes na atuação de práticas colaborativas e, em fases posteriores, reforçar essa experiência, promovendo a interação entre profissionais para desenvolver competências colaborativas. Métodos de aprendizado interativos, como seminários, *shadowing*, resolução de problemas, simulação, prática clínica e e-learning, são fundamentais para essa formação (Reeves, 2016). A EIP, portanto, é crucial para formar profissionais capazes de atuar em equipe, promovendo a integralidade do cuidado e

respondendo às complexas necessidades da saúde da população (Batista, 2012; Silva *et al.*, 2019; Baquião *et al.*, 2020).

Costa e colaboradores (2023) realizaram um estudo com o objetivo de mapear as experiências de EIP da Universidade de São Paulo (USP) – campus São Paulo. Os resultados mostraram que a maioria dos professores não participava dessas experiências (70,4%) e que, quando presentes, envolviam um número reduzido de docentes e estudantes, ocorrendo predominantemente em atividades extracurriculares ou de extensão, embora muitas já estejam consolidadas de seis a dez anos. Além disso, evidenciou-se diversidade nas estratégias de ensino e avaliação – com destaque para discussão em grupos e aulas expositivas dialogadas – bem como a necessidade de maior apoio institucional e desenvolvimento docente para ampliar e fortalecer a EIP no contexto analisado.

O estudo de Medeiros, Forte e Toassi (2024) analisou a EIP no contexto de uma Residência Multiprofissional, a partir da percepção de profissionais residentes. Os resultados evidenciaram que a APS constitui um espaço potente para o desenvolvimento da EIP, favorecendo o aprendizado compartilhado entre diferentes profissões, a troca de saberes e o reconhecimento de papéis no trabalho em equipe. Práticas como reuniões de equipe, discussão de casos, visitas domiciliares e atendimentos multiprofissionais contribuíram para a construção de competências colaborativas, com destaque para a comunicação interprofissional e a resolução de conflitos. Contudo, o estudo aponta fragilidades na intencionalidade pedagógica da EIP no currículo, indicando a necessidade de maior sistematização teórico-conceitual e integração entre ensino e prática para fortalecer a formação interprofissional.

A implementação da EIP enfrenta desafios complexos que permeiam diferentes dimensões. No âmbito técnico e do conhecimento, destaca-se a fragmentação do saber e a tensão entre as atividades colaborativas e as competências específicas de cada núcleo profissional (Costa, 2017; Peduzzi *et al.*, 2020). No campo pedagógico, evidencia-se a incerteza dos estudantes sobre os objetivos da aprendizagem compartilhada e resistências baseadas em estereótipos prévios (Reeves, 2016; Prevedello; Góes; Cyrino, 2022). Além disso, observa-se barreiras estruturais e institucionais, que incluem a falta de suporte financeiro, burocracia acadêmica e a necessidade de reformas curriculares para garantir a sustentabilidade das práticas (Organização Mundial da Saúde, 2010; Samarasekera *et al.*, 2022; Prevedello, Góes e Cyrino, 2022; Girundi; Toassi, 2026). Acrescenta-se a falta de preparo pedagógico dos educadores/preceptores como uma das barreiras mais frequentemente citadas – tanto internacionalmente quanto no Brasil – o que contribui para a implementação inconsistente da

EIP em diferentes cenários de educação na saúde (Vasconcelos *et al.*, 2024; Souza; Oliveira; Leonello, 2025; Bueno *et al.*, 2025; Girundi; Toassi, 2026).

Segundo a revisão sistemática de Kong, Briggs e Xyrichis (2025), a eficácia da EIP não está associada a uma estratégia de ensino isolada, mas na combinação de componentes pedagógicos estruturados que atendam diferentes objetivos de aprendizagem. O estudo destaca que as intervenções baseadas em simulação são eficazes na modificação de atitudes e na compreensão dos papéis profissionais. Em contrapartida, experiências de aprendizagem em cenários baseados na prática e no serviço demonstra um impacto mais significativo no desenvolvimento de habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Os achados evidenciam que intervenções mais efetivas tendem a ser fundamentadas em referenciais teóricos, ocorrer em contextos interprofissionais e apresentar objetivos de aprendizagem definidos, aspectos considerados essenciais para a consolidação das competências colaborativas.

Torna-se essencial, neste contexto, a promoção da EIP por gestores da saúde e a estruturação de propostas de educação permanente em saúde (EPS) que incluam a EIP. Tais medidas são estratégias para consolidar práticas de educação e de trabalho interprofissional colaborativo, reforçando seu papel no desenvolvimento profissional e na melhoria da qualidade da atenção aos usuários-famílias-comunidade.

7 PRODUTO TÉCNICO

Programas de Mestrado Profissional (MP) da área da Saúde Coletiva, como o PPG EnSau, fomentam a produção de pesquisas que sejam potentes para estimular o desenvolvimento de produções técnicas que visem transformar a realidade nos serviços do SUS e na sociedade, integrando a formação profissional, a pesquisa e o contexto de atuação do pesquisador (Freire; Guerrini; Dutra, 2016; Brasil, 2019).

Buscando ampliar o alcance das percepções que emergiram nos relatos dos participantes da pesquisa durante as entrevistas e levando em consideração a abrangência social esperada, este estudo desenvolveu como produto técnico um relatório técnico conclusivo (eixo 4: serviços técnicos). O produto emerge, assim, de pesquisa realizada durante a formação da pesquisadora principal no MP/PPG EnSau e trata-se de um texto elaborado de maneira concisa, contendo informações sobre a pesquisa realizada (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2019). Seu conteúdo aborda o significado atribuído pelos profissionais sobre o trabalho em equipe, aspectos da formação, potencialidades, desafios e estratégias para qualificação. A partir dos achados, recomendações voltadas para o fortalecimento de práticas interprofissionais colaborativas na ESF são apresentadas. O relatório tem como público de interesse a equipe gestora das Coordenadorias de Saúde de Porto Alegre, gestores e profissionais que atuam na ESF. A intenção é mostrar a relevância dos resultados e considerações finais da pesquisa realizada em termos de aplicabilidade e mudanças/qualificação nos processos de trabalho em equipe e práticas de cuidado na ESF.

O Quadro 5 apresenta a ficha técnica do produto, considerando as recomendações do Grupo de Trabalho de Produção Técnica, elaborado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2019). Está organizado de acordo com os campos: finalidade do produto; objetivos de desenvolvimento sustentável; público de interesse; natureza do produto; avanços tecnológicos/grau de novidade; divulgação do produto; aplicabilidade/replicabilidade do produto técnico; projeto de pesquisa vinculado ao produto; objetivo do projeto de pesquisa vinculado ao produto; linha de pesquisa vinculada ao produto; setor da sociedade beneficiado pelo produto; área impactada pelo produto; discente do MP autora; docente permanente do MP autora; e fonte de financiamento.

O relatório técnico conclusivo está apresentado no Apêndice D.

Quadro 5 – Descrição do produto técnico.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Relatório técnico conclusivo (Eixo 4: Serviços técnicos)
FINALIDADE DO PRODUTO	Desenvolver relatório sobre o tema do trabalho em equipe na ESF, apresentando os principais achados da pesquisa e recomendações para o fortalecimento do trabalho colaborativo interprofissional nas equipes da ESF
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Boa saúde e bem-estar Educação de qualidade
PÚBLICO DE INTERESSE	Equipe gestora das Coordenadorias de Saúde de Porto Alegre (Norte, Sul, Leste e Oeste) Gestores e profissionais da ESF
NATUREZA DO PRODUTO	Documento eletrônico (formato pdf)
AVANÇOS TECNOLÓGICOS/ GRAU DE NOVIDADE	Produto com médio teor inovativo: combinação de conhecimentos pré-estabelecidos
DIVULGAÇÃO DO PRODUTO	Repositório Digital da UFRGS – LUME Página do PPG EnSau <i>ResearchGate</i>
APLICABILIDADE/ REPLICABILIDADE DO PRODUTO TÉCNICO	A produção possui potencial para uma alta aplicabilidade no município onde o estudo foi realizado. Como ficará disponível no LUME, pode ser aplicado em novos contextos
PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PRODUTO	Trabalho em equipe: significado, potencialidades e desafios na percepção de profissionais da Estratégia Saúde da Família (nº 46833)
OBJETIVO DO PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PRODUTO	Compreender o significado do trabalho em equipe, identificando aspectos da formação, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação, na percepção de profissionais que atuam na ESF
LINHA DE PESQUISA VINCULADA AO PRODUTO	Processos de Ensino na Saúde
SETOR DA SOCIEDADE BENEFICIADO PELO PRODUTO	Saúde/Estratégia Saúde da Família
ÁREA IMPACTADA PELO PRODUTO	Saúde Coletiva
DISCENTE DO MP AUTORA	Cirurgiã-dentista Jéssica Rodriguez Strey
DOCENTE PERMANENTE DO MP AUTORA	Profa. Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi
FONTE DE FINANCIAMENTO	Recursos próprios

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo qualitativo de base fenomenológica teve como objetivo compreender o significado do trabalho em equipe na percepção de profissionais que atuam na ESF, identificando aspectos da formação, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, gravadas e transcritas na íntegra. O material textual produzido pelas entrevistas foi submetido à análise de conteúdo proposta por Bardin, e interpretado com base na fenomenologia da percepção e no referencial teórico da educação e do trabalho interprofissional em saúde.

Os profissionais participantes do estudo relataram pouca ou nenhuma vivência interprofissional durante a graduação, evidenciando a predominância de um modelo de ensino uniprofissional, centrado nos saberes específicos de cada curso/núcleo profissional. Em contraste, a residência foi identificada como o principal espaço de aprendizado compartilhado com outros núcleos profissionais, contribuindo para uma maior segurança para atuar em equipe no SUS. Essa segurança foi sendo consolidada também a partir da vivência profissional, na rotina de trabalho no SUS.

O trabalho em equipe foi compreendido pelos profissionais do estudo como aspecto central para a qualidade do cuidado na ESF, por meio da atuação conjunta, com complementaridade de saberes e responsabilização compartilhada. A metáfora da ‘engrenagem’ utilizada pelos participantes sintetiza essa compreensão: cada profissional é parte de um conjunto cujo funcionamento depende da integração entre todos. Esse significado, construído na experiência cotidiana, reafirma o trabalho colaborativo interprofissional como estratégia para a garantia ao princípio da integralidade do SUS.

A comunicação efetiva foi identificada como essencial para a constituição do trabalho colaborativo e para a resolução de conflitos. O conhecimento dos papéis profissionais no cotidiano do trabalho na ESF também se apresentou como elemento importante para a organização do trabalho em equipe.

As reuniões de equipe, as visitas domiciliares e as interconsultas emergiram como dispositivos facilitadores para uma prática interprofissional na ESF, sendo espaços onde o cuidado é discutido, planejado e compartilhado. A inserção da eMulti foi percebida de forma positiva, com impacto especialmente nos casos de saúde mental e em situações de maior complexidade, embora seu processo de integração ainda esteja em construção.

Os profissionais apontaram desafios que não se resolvem no plano individual. No campo das relações interprofissionais, destacaram-se as dificuldades de interação entre as

profissões, a resistência de alguns profissionais à atuação integrada e os conflitos e ruídos na comunicação. No plano estrutural, foram mencionados o tempo insuficiente das reuniões, a ausência de garantia de participação de todos, a alta demanda de atendimentos, a sobrecarga de trabalho, as equipes incompletas e a rotatividade de trabalhadores. Tais desafios evidenciam que o fortalecimento do trabalho em equipe na ESF requer respostas também nas dimensões da gestão e de modelos de atenção à saúde, e não apenas da formação profissional.

A garantia dos momentos de discussão coletiva, a ampliação do tempo das reuniões e o investimento em capacitações foram as principais estratégias de qualificação apontadas pelos profissionais. São achados que reforçam a centralidade da EPS como espaço de reflexão crítica sobre as práticas e de desenvolvimento intencional de competências colaborativas. Para que a EPS cumpra esse papel, é necessário que vá além de capacitações técnicas pontuais, constituindo-se como espaço seguro de interação, fala e escuta entre os profissionais, com foco na interprofissionalidade.

Esta pesquisa contribuiu para a produção de evidências qualitativas sobre o significado do estar e trabalhar em equipe na ESF, a partir da perspectiva de profissionais inseridos no cotidiano do trabalho na APS. Recomenda-se que pesquisas futuras incluam a perspectiva de todos os profissionais envolvidos no processo de trabalho da ESF, entre eles os da eMulti, além de usuários e famílias, a fim de aprofundar a compreensão das dinâmicas do trabalho interprofissional colaborativo na APS/ESF.

Como produto técnico decorrente dos resultados do estudo, foi elaborado relatório técnico conclusivo sobre o trabalho em equipe na ESF direcionado à equipe gestora das Coordenadorias de Saúde do município de Porto Alegre, gestores e profissionais da ESF, com o objetivo de apresentar os principais achados da pesquisa e recomendações para o fortalecimento do trabalho interprofissional colaborativo. O relatório será encaminhado às Coordenadorias de Saúde de Porto Alegre e aos gestores e profissionais participantes. Os materiais de pesquisa serão utilizados para fins científicos, fornecendo elementos para a construção de artigo, resumos a serem apresentados em eventos científicos, e demais publicações/produções técnicas que dela resultem.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA. **Caderno de Orientações para implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 2025**. Brasília, DF: Associação Brasileira de Educação Médica, 2026.
- AKBAR, M. A. *et al.* Interprofessional collaboration in primary care: concept analysis. **Journal of Caring Sciences**, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 267-277, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.34172/jcs.025.33428>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- ALBUQUERQUE, E. R. N.; SANTANA, M. C. C. P.; ROSSIT, R. A. S. Multiprofessional residences in health as promoters of interprofessional training: perception of nutritionists about collaborative practices. **Demetra**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 605-619, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/demetra.2018.33495>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- ALMEIDA, M. C. P. de; MISHIMA, S. M. O desafio do trabalho em equipe na atenção à Saúde da Família: construindo “novas autonomias” no trabalho. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 5, p. 150-153, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832001000200012>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- ANDRADE, L. O. M. de; PONTES, R. J. S.; MARTINS JUNIOR, T. A descentralizacao no marco da reforma sanitaria no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, Washington, v. 8, n. 1-2, p. 84-92, 2000. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/8778>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- ARANTES, L. J.; SHIMIZU, H. E.; MERCHÁN-HAMANN, E. Contribuições e desafios da Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1499-1509, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015215.19602015>. Acesso em: 3 abr. 2026.
- ARAÚJO, M. B. de S.; ROCHA, P. de M. Trabalho em equipe: um desafio para a consolidação da estratégia de saúde da família. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 455-464, abr. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000200022>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BAQUIÃO, A. P. S. S. *et al.* Educação interprofissional em saúde: revisão integrativa da literatura brasileira (2008-2018). **Revista Psicologia e Saúde**, Campo Grande, v. 12, n. 4, p. 125-139, out./dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.20435/pssa.vi.1275>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BARR, H. Competent to collaborate: towards a competency-based model for interprofessional education. **Journal of Interprofessional Care**, Abingdon, v. 12, n. 2, p. 181-187, 1998. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/13561829809014104?journalCoe=ijic2>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BARR, H.; LOW, H. **Introdução à educação interprofissional**. Reino Unido: Centro para o Avanço da Educação Interprofissional (CAIPE), 2013.

BATISTA, N. A. Educação interprofissional em saúde: concepções e práticas. **Cad. Fnepas**, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 25-28, 2012. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/712281334/Educacao-interprofissional-Nildo-Batista>. Acesso em: 6 maio 2026.

BISPO JÚNIOR, J. P.; ALMEIDA, P. F. de. Equipes multiprofissionais (eMulti): potencialidades e desafios para a ampliação da atenção primária à saúde no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 10, e00120123, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT120123>. Acesso em: 4 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 20 set. 1990a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm. Acesso em: 6 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade no SUS. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 31 dez. 1990b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18142.htm. Acesso em: 6 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 198/GM**, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1832.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466/2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 12 dez. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>. Acesso em: 12 abr. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510/2016. Diretrizes éticas específicas para as ciências humanas e sociais. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 12 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Secretaria de Atenção à Saúde. **Portaria nº 2.436**, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 11 abr. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 580, de 22 de março de 2018. Dispõe sobre as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 22 mar. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/acesso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2018/resolucao-no-580.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 97, 13 nov. 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180>. Acesso em: 11 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 21 de junho de 2021. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Odontologia e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 77, 22 jun. 2021. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Resolucao-cne-ces-003-2021-06-21.pdf>. Acesso em: 6 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023. Institui, define e cria incentivo financeiro federal para implantação, custeio e desempenho das equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt0635_22_05_2023.html. Acesso em: 12 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2024. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/658231/Lei_geral_protecao_dados_pessoais_1ed.pdf. Acesso em: 6 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 30 de setembro de 2025. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Medicina e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 35, 1 out. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/resolucoes-do-cne/ces/2021/rces003_21.pdf. Acesso em: 6 maio 2026.

BRINCO, R.; FRANÇA, T.; MAGNAGO, C. PET-Saúde/Interprofissionalidade e o desenvolvimento de mudanças curriculares e práticas colaborativas. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. esp. 6, p. 55-69, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E606>. Acesso em: 26 abr. 2026.

BUENO, T. M. M. *et al.* Educação Interprofissional na visão dos docentes: revisão integrativa. **Educação**, Santa Maria, v. 50, p. 1-23, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/70338>. Acesso em: 12 abr. 2026.

CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE. **A national interprofessional competence framework**. Vancouver: Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2010. Disponível em: <https://phabc.org/wp-content/uploads/2015/07/CIHCNational-Interprofessional-Competency-Framework.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2026.

CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE. **Competency Framework for Advancing Collaboration**. Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC), Vancouver, Apr. 2024. Disponível em: <https://cihc-cpis.com/wp-content/uploads/2024/06/CIHC-Competency-Framework.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2026.

CARDOSO, C. G.; HENNINGTON, E. A. Trabalho em equipe e reuniões multiprofissionais

de saúde: uma construção à espera pelos sujeitos da mudança. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 9, p. 85-112, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462011000400005>. Acesso em: 12 abr. 2026.

CASANOVA, I. A.; BATISTA, N. A.; MORENO, L. R. Interprofessional education and shared practice in multiprofessional health residency programs. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, p. 1325-1337, 2018. Supl. 1. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0186>. Acesso em: 8 abr. 2026.

CECCIM, R. B. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 161-177, set. 2004/fev. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/jC4gdtHC8RPLWSW3WG8Nr5k/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

CONILL, E. M. Ensaio histórico-conceitual sobre a Atenção Primária à Saúde: desafios para a organização de serviços básicos e da Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, p. s7-s16, 2008. Supl. 1. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2008001300002>. Acesso em: 12 abr. 2026.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. GT de Produção Técnica. **Produção Técnica**. Ministério da Educação: Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf>. Acesso em: 12 abr. 2026.

COSTA, M. V. A Educação Interprofissional no contexto brasileiro: algumas reflexões. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 56, p. 197-198, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0311>. Acesso em: 12 abr. 2026.

COSTA, M. V. da. A potência da educação interprofissional para o desenvolvimento de competências colaborativas no trabalho em saúde. In: TOASSI, R. F. C. (org.). **Interprofissionalidade e formação na saúde: onde estamos?**. 1. ed. Porto Alegre: Rede Unida, 2017. p. 14-27. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/183942/001064798.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 12 abr. 2026.

COSTA, D. A. S. *et al.* National curriculum guidelines for health professions 2001-2004: an analysis according to curriculum development theories. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, n. 67, p. 1183-1196, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0376>. Acesso em: 29 mar. 2026.

COSTA, A. M.; ALMEIDA, R. M.; GOMES, J. F. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde: movimento em defesa do direito à saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 44, p. 135-141, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/SwMJG4gTGRyrrRJdKxPZTD/>. Acesso em: 8 abr. 2026.

COSTA, J. B. *et al.* Caracterização das experiências de educação interprofissional na formação em saúde na Universidade de São Paulo. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 57, e20230118, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0118>. Acesso em: 15 abr. 2026.

D'AMOUR, D. *et al.* The conceptual basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks. **Journal of Interprofessional Care**, Abingdon, v. 19, p. 116-131, 2005. Supl. 1. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13561820500082529>. Acesso em: 16 abr. 2026.

D'AMOUR, D. *et al.* A model and typology of collaboration between professionals in healthcare organizations. **BMC Health Services Research**, London, v. 8, p. 188, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1472-6963-8-188>. Acesso em: 16 abr. 2026.

DAMASCENA, C. G. *et al.* Avaliação da resolutividade clínico-assistencial de equipes multiprofissionais em um município do nordeste brasileiro. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 49, n. 145, e9941, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2358-289820251459941P>. Acesso em: 12 abr. 2026.

ESCALDA, P.; PARREIRA, C. M. de S. F. Dimensões do trabalho interprofissional e práticas colaborativas desenvolvidas em uma unidade básica de saúde, por equipe de Saúde da Família. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, p. 1717-1727, 2018. Supl. 2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0818>. Acesso em: 13 abr. 2026.

ELY, L. I.; TOASSI, R. F. C. Integração entre currículos na educação de profissionais da Saúde: a potência para educação interprofissional na graduação. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, p.1563-1575, 2018. Supl. 2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0658>. Acesso em: 12 abr. 2026.

FARINHA, A. L. *et al.* Educação interprofissional nas práticas de integração ensino-serviço-comunidade: perspectivas de docentes da área de saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. spe. 6, p. 55-69, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E606>. Acesso em: 15 abr. 2026.

FERLA, A. A.; FALCÃO, A. P.; MACEDO, G. P. Ensino cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho: das intenções à ação em equipes de saúde. In: FERLA, A. A. *et al.* (org.). **Ensino cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho**: das intenções à ação em equipes de saúde. Porto Alegre: Rede Unida, 2019. p. 15-25. Disponível em: <https://editora.redeunida.org.br/project/ensino-cooperativo-e-aprendizagem-baseada-no-trabalho-das-intencoes-a-acao-em-equipes-de-saude/>. Acesso em: 16 abr. 2026.

FRANCO, R. S. *et al.* O conceito de competência: uma análise do discurso docente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. 173-181, abr./jun. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000200003>. Acesso em: 12 abr. 2026.

FRENK, J. *et al.* Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. **The Lancet**, London, v. 376, n. 9756, p. 1923-1958, 2010. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(10\)61854-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(10)61854-5). Acesso em: 8 abr. 2026.

FRENK, J. *et al.* Challenges and opportunities for educating health professionals after the COVID-19 pandemic. **The Lancet**, London, v. 400, p. 1539-1556, 2022. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(22\)02092-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)02092-x). Acesso em: 8 abr. 2026.

FREIRE, G. G.; GUERRINI, D.; DUTRA, A. O Mestrado Profissional em Ensino e os Produtos Educacionais: a pesquisa na formação docente. **Porto das Letras**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 100-114, 2016. Disponível em: <https://betas.uft.edu.br/periodicos/index.php/portodasletras/article/view/2658>. Acesso em: 14 mar. 2026.

FONTANELLA, B. J. B. *et al.* Amostragem em pesquisas qualitativas: proposta de procedimentos para constatar saturação teórica. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 388-394, fev. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000200020>. Acesso em: 16 abr. 2026.

FORTE, F. D. S. *et al.* Educação Interprofissional e o Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde/Rede Cegonha: potencializando mudanças na formação acadêmica. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 58, p. 796-798, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0720>. Acesso em: 16 abr. 2026.

FOX, A.; REEVES, S. Interprofessional collaborative patient-centred care: a critical exploration of two related discourses. **Journal of Interprofessional Care**, Abingdon, v. 29, n. 2, p. 113-118, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3109/13561820.2014.969803>. Acesso em: 30 mar. 2026.

FREIRE FILHO, J. R. *et al.* Educação Interprofissional nas políticas de reorientação da formação profissional em saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. esp. 1, p. 86-96, ago. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042019000500086&tlng=pt. Acesso em: 13 abr. 2026.

GARCIA, A. C. P. *et al.* O trabalho em equipe na estratégia saúde da família. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, Santa Cruz do Sul, v. 5, n. 1, p. 31-36, abr. 2015. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/5314>. Acesso em: 15 abr. 2026.

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. de. Atenção primária à saúde. In: GIOVANELLA, L. *et al.* (org.). **Políticas e Sistema de Saúde no Brasil**. 2. ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012. p. 493-545. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/c5nm2/pdf/giovanella-9788575413494.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2026.

GIOVANELLA, L. *et al.* A provisão emergencial de médicos pelo Programa Mais Médicos e a qualidade da estrutura das unidades básicas de saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 9, p. 2697-2708, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015219.16052016>. Acesso em: 6 maio 2026.

GIOVANELLA, L. *et al.* De Alma-Ata a Astana: Atenção primária à saúde e sistemas universais de saúde: compromisso indissociável e direito humano fundamental. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, e00012219, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00012219>. Acesso em: 15 abr. 2026.

GIOVANELLA, L.; FRANCO, C. M.; ALMEIDA, P. F. de. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, p. 1475-1482, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020254.01842020>. Acesso em: 11 abr. 2026.

GIRUNDI, C.; TOASSI, R. F. C. Educação interprofissional na graduação em saúde: análise documental em universidade pública do Sul do Brasil. **Saúde em Redes**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, e5046, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2026v12n1.5046>. Acesso em: 12 abr. 2026.

GOMES, E. dos S.; ANSELMO, M. E. de O.; LUNARDI FILHO, W. D. As reuniões de equipe como elemento fundamental na organização do trabalho. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [s. l.], v. 53, p. 472-480, 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/LYpryzN6C5GzWW5XNsF9VYZ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 15 abr. 2026.

GRIGGIO, A. P. *et al.* Analysis of an interprofessional education activity in the occupational health field. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [s. l.], v. 28, e3247, abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3228.3247>. Acesso em: 14 abr. 2026.

GUIMARÃES, B. E. de B.; BRANCO, A. B. de A. C. Trabalho em equipe na atenção básica à saúde: pesquisa bibliográfica. **Revista Psicologia e Saúde**, Campo Grande, v. 12, n. 1, p. 143-155, 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2177-093X2020000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 12 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022: resultados do universo**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/>. Acesso em: 9 abr. 2026.

KANNO, N. de P. *et al.* A colaboração interprofissional na atenção primária à saúde na perspectiva da ciência da implementação. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, e00213322, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT213322>. Acesso em: 15 abr. 2026.

KELL, M. C. G.; SHIMIZU, H. E. Existe trabalho em equipe no Programa Saúde da Família? **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, p. 1533-1541, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000700065>. Acesso em: 15 abr. 2026.

KONG, L.; BRIGGS, E.; XYRICHIS, A. What is the effect of different interprofessional education teaching strategies on healthcare professions students' interprofessional learning outcomes? A systematic narrative review. **Nurse Education in Practice**, London, v. 83, p. 104255, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595325000113?via%3Dihub>. Acesso em: 12 abr. 2026.

LAVRAS, C. Atenção Primária à Saúde e a organização de redes regionais de atenção à saúde no Brasil. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 867-874, out./dez. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902011000400005>. Acesso em: 15 abr. 2026.

LARROSA, J. B. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista Brasileira de Educação**, [s. l.], n. 19, p. 20-28, jan./abr. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 abr. 2026.

LEWGOY, A. M. B.; BUENO, D.; TOASSI, R. F. C. (org.). **Integrar para aprender sobre saúde: a experiência interprofissional de cuidado nos territórios**. 1. ed. Porto Alegre: Editora Rede Unida, 2024. Disponível em: <https://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2024/09/Livro-Integrar-para-aprender-sobre-saude.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2026.

LIMA, R. B. D. *et al.* A interprofissionalidade nas diretrizes curriculares nacionais brasileiras dos cursos da área da saúde. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas; Sorocaba, v. 29, e024020, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-57652024v29id279379>. Acesso em: 31 mar. 2026.

LOPES, D. D.; RODRIGUES, F. D.; BARROS, N. D. V. de M. Para além da doença: integralidade e cuidado em saúde. **Psicologia em Pesquisa**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 68-73, 2012. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472012000100009. Acesso em: 15 abr. 2026.

MACHADO, H. S. V.; MELO, E. A.; PAULA, L. G. N. Medicina de família e comunidade na saúde suplementar do Brasil: implicações para o Sistema Único de Saúde e para os médicos. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 11, e00068419, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/9vH6XjYzJ7yK8mGg3m8wKzv/>. Acesso em: 11 abr. 2026.

MARTINS, M. B.; CARBONAI, D. Atenção primária à saúde: a trajetória brasileira e o contexto local em Porto Alegre (RS). **REAd**, Porto Alegre, v. 27, n. 3, p. 725-748, set./dez. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.331.107905>. Acesso em: 8 abr. 2026.

MEDEIROS, A. V.; FORTE, F. D. S.; TOASSI, R. F. C. Educação interprofissional na residência multiprofissional em Atenção Primária à Saúde: análise fenomenológica. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 143, e9167, 2024. Disponível em: <https://www.saudeemdebate.org.br/sed/article/view/9167>. Acesso em: 6 abr. 2026.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da percepção**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MIRA, M. L. G. *et al.* Entre a distância e a proximidade: formação e trabalho em tempos de pandemia. a experiência do PET Interprofissionalidade em São Vicente. In: QUEIRÓZ, M. F. F. *et al.* (org.). **Em foco a formação interprofissional: experiências dos grupos PET-Saúde**. Porto Alegre, Rede Unida, 2022. p. 210-232. Disponível em: <https://editora.redeunida.org.br/project/em-foco-a-formacao-interprofissional-experiencias-dos-grupos-pet-saude/>. Acesso em: 16 abr. 2026.

MIORIN, J. D. *et al.* Colaboração interprofissional entre as equipes de saúde dos serviços de urgência e emergência: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 9, n. 2, e78922074, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i2.2074>. Acesso em: 13

abr. 2026.

MOROSINI, M. V. G. C.; FONSECA, A. F.; LIMA, L. D. Política Nacional de Atenção Básica 2017: retrocessos e riscos para o Sistema Único de Saúde. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 116, p. 11-24, 2018. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8Qp7yYgkq5t7K8rHjXr7Y9x/>. Acesso em: 11 abr. 2026.

NANCARROW, S. A. *et al.* Ten principles of good interdisciplinary team work. **Human Resources for Health**, Londres, v. 11, n. 1, p. 19, 2013. Disponível em: <http://www.human-resources-health.com/content/11/1/19>. Acesso em: 30 mar. 2026.

OGATA, M. N. *et al.* Interfaces between permanent education and interprofessional education in health. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, e03733, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020018903733>. Acesso em: 28 mar. 2026.

OLIVEIRA, S. A. de *et al.* Conquistas e desafios do trabalho em equipe nos 30 anos da Estratégia Saúde da Família: ensaio teórico. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 12, p. 1-16, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320253012.06822025>. Acesso em: 15 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Marco para ação em educação interprofissional e prática colaborativa**. Genebra: OMS, 2010. Disponível em: https://www.anamt.org.br/site/arquivos/meus_arquivos/arquivos/meu_arquivo/m5086a98b7c2b9.pdf. Acesso em: 12 abr. 2026.

ORTEGA, F.; PELE, A. Brazil's unified health system: 35 years and future challenges. **The Lancet Regional Health - Americas**, London, v. 28, 100631, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100631>. Acesso em: 12 abr. 2026.

PADILLA, M. Educação e prática interprofissional no Sistema Único de Saúde: práticas compartilhadas e exigências de interação em equipe na saúde. In: FERLA, A. A. *et al.* (org.). **Ensino cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho: das intenções à ação em equipes de saúde**. Porto Alegre: Rede Unida, 2019. p. 8-14. Disponível em: <https://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Livro-Pr%C3%A1ticas-compartilhadas-e-exig%C3%A2ncias-de-intera%C3%A7%C3%A3o-envolvimento-e-trocas-em-equipe-na-sa%C3%BAde.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2026.

PAIM, J. S. **Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e crítica**. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/4ndgv/pdf/paim-9788575413593.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2026.

PAIM, J. S. A reforma sanitária brasileira e o CEBES. In: CEBES. **Material didático desenvolvido para o curso Reforma Sanitária: trajetória e rumos do SUS**. Repositório UFBA, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6419>. Acesso em: 15 abr. 2026.

PAIM, J. *et al.* The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **The Lancet**, London, v. 377, n. 9779, p. 1778-1797, 2011. Disponível em:

[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(11\)60054-8/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60054-8/abstract). Acesso em: 15 abr. 2026.

PAULA, A. P. P. de. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão social. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 45, n. 1, p. 36-49, jan./mar. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/HqKgvKNRxxMmCyxK7jbJz8g/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 abr. 2026.

PAULA, G. B. de; SOUZA, R. S. de; TOASSI, R. F. C. Atividade de integração ensino-serviço-comunidade com foco na educação interprofissional: significados para o trabalho em equipe. **Saúde em Redes**, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 4386, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2024v10n3.4386>. Acesso em: 30 abr. 2026.

PEDUZZI, M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 35, n. 1, p. 103-109, fev. 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102001000100016>. Acesso em: 15 abr. 2026.

PEDUZZI, M. *et al.* Educação interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 4, p. 977-983, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000400029>. Acesso em: 12 abr. 2026.

PEDUZZI, M. O SUS é interprofissional. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 56, p. 199-201, jan. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0383>. Acesso em: 16 abr. 2026.

PEDUZZI, M. Educação interprofissional para o desenvolvimento de competências colaborativas em saúde. In: TOASSI, R. F. C. (org.). **Interprofissionalidade e formação na saúde: onde estamos?** [recurso eletrônico]. 1. ed. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2017. p. 40-48. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/183942/001064798.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2026.

PEDUZZI, M.; AGRELI, H. F. Trabalho em equipe e prática colaborativa na Atenção Primária à Saúde. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, p. 1525-1534, 2018. Supl. 2. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0827>. Acesso: 8 abr. 2026.

PEDUZZI, M. *et al.* Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 18, e0024678, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00246>. Acesso em: 15 abr. 2026.

PEDUZZI, M. *et al.* Team climate and patients' perception of primary healthcare attributes in Brazil: a cross-sectional study. **Journal of Interprofessional Care**, Abingdon, v. 38, n. 4, p. 705-712, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13561820.2024.2351006>. Acesso em: 16 abr. 2026.

PEREGO, M. G.; BATISTA, N. A. Shared learning in the multiprofessional healthcare residency. **Tempus - Actas de Saúde Coletiva**, Brasília, v. 10, n. 4, p. 39-51, 2016. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/03/881114/20163.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2026.

PEREIRA, A. L. L. *et al.* A comunicação interprofissional como uma importante ferramenta do processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 10, e338101018942, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18942>. Acesso em: 7 abr. 2026.

PINTO, L. F.; GIOVANELLA, L. Do programa à estratégia saúde da família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1903-1914, jun. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018>. Acesso em: 16 abr. 2026.

PRADO, C. L. S. R. *et al.* Comunicação interprofissional e participação do usuário na Estratégia Saúde da Família. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 32, n. 2, e220823, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023220823pt>. Acesso em: 3 abr. 2026.

PREVEDELLO, A. S.; GÓES, F. dos S. N. de; CYRINO, E. G. Educação interprofissional na formação em saúde no Brasil: scoping review. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 46, n. 3, e110, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v46.3-20210006>. Acesso em: 3 abr. 2026.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. Edital de Chamamento Público nº 002/2022: seleção de organização da sociedade civil para gerenciamento, administração, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) do Município de Porto Alegre. **Diário Oficial de Porto Alegre**, Porto Alegre, ano XXVII, n. 6771, p. 45, 1 jun. 2022. Disponível em: https://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/4396_ce_20220601_executivo.pdf. Acesso em: 12 abr. 2026

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. Diretoria de Atenção Primária à Saúde. **Portfólio Atenção Primária à Saúde**. Porto Alegre: SMS, 2023. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1zjmGa3kmKJTfDoyc4LfdSfY5Nykig9q/view>. Acesso em: 9 abr. 2026.

REEVES, S. *et al.* A conceptual framework for interprofessional teamwork. In: REEVES, S. *et al.* **Interprofessional teamwork for health and social care**. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2010. p. 57-76. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/9781444325027.ch4>. Acesso em: 12 abr. 2026.

REEVES, S. *et al.* Interprofessional education: effects on professional practice and healthcare outcomes. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], issue 3, art. n. CD002213, p. 1-41, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002213.pub3>. Acesso em: 12 abr. 2026.

REEVES, S. Porque precisamos da educação interprofissional para um cuidado efetivo e seguro. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 56, p. 185-196, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622014.0092>. Acesso em: 12 abr. 2026.

REEVES, S. *et al.* Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], issue 6, art. n. CD000072, p. 1-38, 2017. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6481564/pdf/CD000072.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2026.

REEVES, S.; XYRICHIS, A.; ZWARENSTEIN, M. Teamwork, collaboration, coordination, and networking: why we need to distinguish between different types of interprofessional practice. **Journal of Interprofessional Care**, Abingdon, v. 32, n. 1, p. 1-3, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1400150>. Acesso em: 13 abr. 2026.

REWA, T. *et al.* Shared practices among primary health care workers: A time-motion study. **BMC Health Services Research**, London, v. 25, n. 1, p. 317, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12439-9>. Acesso em: 16 abr. 2026.

SAMARASEKERA, D. D. *et al.* Challenges and opportunities in interprofessional education and practice. **The Lancet**, London, v. 400, n. 10362, p. 1495-1497, 2022. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01275-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01275-2). Acesso em: 26 abr. 2026.

STARFIELD, B. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia**. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/publicacoes/atencao_primaria_pl.pdf. Acesso em: 15 abr. 2026.

SILVA, R. H. A. da; SCAPIN, L. T.; BATISTA, N. A. B. Avaliação da formação interprofissional no ensino superior em saúde: aspectos da colaboração e do trabalho em equipe. **Avaliação**, Campinas, v. 16, n. 1, p. 167-184, mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772011000100009>. Acesso em: 14 abr. 2026.

SILVA, N. F. *et al.* Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade: diálogos e ações interdisciplinares possíveis na Atenção Básica. In: FERLA, A. A.; LIMA, M. C.; SANTANA, D. C. (org.). **Ensino cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho: das intenções à ação em equipes de saúde**. Porto Alegre: Rede Unida, 2019. p. 60-73. Disponível em: <https://doi.org/10.18310/9788554329280>. Acesso em: 16 abr. 2026.

SILVA, J. A. M. *et al.* Collective leadership to improve professional practice, healthcare outcomes and staff well-being. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], n. 10, art. n. CD013850, p. 1-47, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013850.pub2>. Acesso em: 13 abr. 2026.

SOUZA, V. R. S. *et al.* Tradução e validação para a língua portuguesa e avaliação do guia COREQ. **Acta Paulista de Enfermagem**, [s. l.], v. 34, eAPE02631, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021AO02631>. Acesso em: 16 abr. 2026.

SOUZA, R. S. de; ELY, L. I.; TOASSI, R. F. C. Educação interprofissional em saúde: aprendizados de uma experiência inovadora de integração entre pessoas, currículos e profissões. **Pro-Posições**, [s. l.], v. 33, e20200011, maio 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2020-0011>. Acesso em: 16 abr. 2026.

SOUZA, C. M. S.; OLIVEIRA, A. C. M.; LEONELLO, V. M. Barriers to preceptorship in interprofessional education: An integrative review. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 30, e11472023, 2025. Supl. 1. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320242911.11472023>. Acesso em: 6 abr. 2026.

TOASSI, R. F. C.; LEWGOY, A. M. B. Práticas Integradas em Saúde I: uma experiência inovadora de integração intercurricular e interdisciplinar. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 57, p. 449-461, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0123>. Acesso em: 8 abr. 2026.

TOASSI, R. F. C. *et al.* The role of interprofessional education in dentistry training: understanding the perception of brazilian dental students. **European Journal of Dental Education**, [s. l.], v. 30, n. 2, p. 253-261, 2026. Disponível em: <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/eje.13112>. Acesso em: 16 abr. 2026.

TONG, A.; SAINSBURY, P.; CRAIG, J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. **International Journal for Quality in Health Care**, Oxford, v. 19, n. 6, p. 349-357, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>. Acesso em: 16 abr. 2026.

TURATO, E. R. **Tratado de metodologia da pesquisa clínico-qualitativa**: construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

VASCONCELOS, J. *et al.* Fatores associados à colaboração interprofissional na Atenção Primária à Saúde: uma análise multinível. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, e10572022, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024291.10572022>. Acesso em: 12 abr. 2026.

VIEIRA, S. A.; MELLO, V. R. C. de. Redimensionamento das Gerências Distritais de Saúde: economia em saúde? **Tempus - Actas de Saúde Coletiva**, Brasília, v. 17, n. 3, p 175-197, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.18569/tempus.v17i3.3326>. Acesso em: 12 abr. 2026.

ANEXO A – TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA



**prefeitura de
PORTO ALEGRE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - DAPS/SMS

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL DA COORDENAÇÃO ONDE SERÁ REALIZADA A PESQUISA

Título da pesquisa: TRABALHO EM EQUIPE : SIGNIFICADO, POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Pesquisador responsável: Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

Instituição: Unidade de Saúde Mato Sampaio

A pesquisa proposta envolve:

- ☐ utilização de dados de usuários e/ou dos serviços de saúde
- ☒ participação de trabalhadores e/ou gestores da saúde
- ☒ atividade em espaço físico da SMS e/ou da PMPA
- ☐ realização de exames e/ou serviços de assistência à saúde com custos para o SUS
- ☐ outras atividades: Clique ou toque aqui para inserir o texto.

O trabalho em equipe é visto como uma ferramenta essencial para a promoção de cuidados integrados e resolutivos, sendo uma estratégia-chave para alcançar a integralidade no Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo tem como objetivo: Compreender o significado do trabalho em equipe na percepção de profissionais da Estratégia Saúde da Família. METODOLOGIA: Estudo de abordagem qualitativa fenomenológica, que será desenvolvido no cenário da Atenção Primária à Saúde/ESF do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A amostra será intencional. Serão convidados a participar do estudo os profissionais que atuam na Unidade de Saúde escolhida (n=18). Serão excluídos da amostra, profissionais que mudem de lotação, ou que estejam em férias/licença ou outro motivo de afastamento no período da coleta de dados. Os dados serão produzidos por meio da realização de entrevistas individuais semiestruturadas, que serão gravadas por equipamento de áudio e transcritas na íntegra. O material textual produzido pelas entrevistas será importado para o software Visual Qualitative Data Analysis (ATLAS.ti) e interpretado pela análise temática de conteúdo. PRODUTO TÉCNICO: Será produzido artigo com os resultados da pesquisa, em periódico da área da Saúde Coletiva (produto bibliográfico) e material didático sobre o tema do trabalho em equipe na ESF (produto técnico) e desenvolvimento de atividade de educação interprofissional com os participantes do estudo (produto técnico). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir com a produção de evidências qualitativas sobre o significado do trabalho em equipe na ESF e com sua qualificação, trazendo a compreensão de aspectos facilitadores e possíveis barreiras.

Eu, Vânia Maria Frantz, matrícula 484766/01, Diretora:

- ☐ Diretoria Geral de Atenção Hospitalar e de Urgência (DGAHU)
- ☒ Diretoria de Atenção Primária em Saúde (DAPS)
- ☐ Diretoria Geral de Vigilância em Saúde (DGVs)
- ☐ Diretoria Geral de Regulação (DGR)
- ☐ Comissão Multiprofissional de Ensino-Serviço e Pesquisa (COMESP) do Hospital de PS
- ☐ Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (ASSEPLA)
- ☐ Outra área/secretaria:

Estou ciente dos termos desta pesquisa e autorizo, após o parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a sua realização.

Obs.: Este documento não autoriza o início de pesquisa, sendo apenas um requisito exigido pelo Comitê de Ética da SMS/PMPA para análise do projeto de pesquisa. Sua finalidade é atestar que a Diretoria da área tem ciência e autoriza a realização do projeto de pesquisa, quando for cumpridas as instâncias de avaliação ética.

file:///C:/Users/seila/Downloads/SMS_Termo_de_Anuencia_Institucional_31746978.html 1/2

26/12/2024, 15:36 SEIPMPA - 31746978 - SMS - Termo de Anuência Institucional

foram cumpridas as instâncias de avaliação ética.

Porto Alegre 23 / 12 / 2024
Diretoria com atribuição delegada para essa autorização, conforme Art. 1, inciso XV da Resolução CNS no. 580/2018.



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Maria Frantz, Diretor(a)**, em 26/12/2024, às 08:10, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **31746978** e o código CRC **066B1290**.

24.0.000128062-3
31746978v3

ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA, CEP UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: TRABALHO EM EQUIPE: SIGNIFICADO, POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Pesquisador: Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 86514325.2.0000.5347

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.783.901

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento Informações Básicas do Projeto, em arquivo intitulado PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2598811_E1.pdf (data 17/07/2025)

TÍTULO

TRABALHO EM EQUIPE: SIGNIFICADO, POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

INTRODUÇÃO

O trabalho em equipe constitui-se como uma modalidade de trabalho coletivo que acontece por meio das relações recíprocas desenvolvidas na interação dos agentes de diferentes áreas profissionais e mediante às múltiplas intervenções técnicas do cotidiano do serviço, na busca de articulações necessárias à integração das ações no cuidado (Peduzzi 2001; Escalda; Parreira, 2018). Caracteriza-se como componente estratégico essencial para lidar com a crescente complexidade das demandas de saúde, favorecendo a qualidade da atenção aos usuários, famílias e comunidades, além de melhorar a satisfação dos profissionais envolvidos

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

(Peduzzi et al., 2020). As limitações das práticas isoladas e fragmentadas de saúde evidenciam a necessidade de uma transição do modelo biomédico tradicional para uma abordagem centrada na integralidade e no cuidado em saúde (Forte et al., 2016; Costa, 2016). Essa transformação destaca a importância do trabalho colaborativo em equipe, orientado pelas necessidades de saúde da população e voltado para a garantia da integralidade do cuidado (Peduzzi, 2016). A implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Brasil promoveu mudanças importantes na organização da atenção básica, criando condições para iniciativas voltadas à reorientação do modelo assistencial (Garcia et al., 2015). Assim, para que a ESF desencadeie um processo de construção de novas práticas, evidencia-se o trabalho em equipe como uma das principais estratégias para promover integralidade nos cuidados de saúde, sendo um dos elementos-chave na reorganização da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) (Kell; Shimizu, 2010; Cardoso; Hennington, 2011; Lopes; Rodrigues; Barros, 2012; Garcia et al., 2015; Guimarães; Branco, 2020). Embora a composição de equipes seja imprescindível para atuar na ESF, ela, por si só, não é suficiente para garantir as práticas do trabalho em equipe. Uma característica essencial do trabalho em equipe é o compartilhamento de ideias e opiniões para a solução de problemas (Gomes; Anselmo; Lunardi Filho, 2000; Araújo; Rocha, 2007). Se essa interação entre os profissionais não ocorrer, existe a possibilidade de repetir a prática fragmentada, desumanizada e centrada no enfoque biológico individual (Almeida; Mishima, 2001; Cardoso; Hennington, 2011; Garcia et al., 2015). Diante da relevância do trabalho em equipe para o cuidado integral e resolutivo das necessidades de saúde dos indivíduos, famílias e comunidade, a seguinte questão de pesquisa foi constituída: "Como profissionais que atuam na ESF percebem o trabalho em equipe, seu significado, potencialidades e desafios?". Este estudo, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Saúde (PPGEnSau) e Mestrado Profissional, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), propõe-se a compreender o significado do trabalho em equipe, identificando potencialidade e desafios, na percepção de profissionais que atuam na ESF.

Estudo de abordagem qualitativa fenomenológica, que será desenvolvido no cenário da Atenção Primária à Saúde/ESF do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Serão convidados a participar do estudo os profissionais que atuam na ESF, incluindo as equipes de saúde bucal (ESB), nas nove US selecionadas do Distrito Sanitário Leste/Coordenadoria de Saúde Leste há pelo menos seis meses e que desempenham funções assistenciais no cotidiano do cuidado (agentes comunitários de saúde, auxiliares de saúde bucal, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem), além do gerente das US (seis gerentes nas

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.783.901

nove US). Os dados serão produzidos por meio da realização de entrevistas individuais semiestruturadas, que serão gravadas por equipamento de áudio e transcritas na íntegra. O material textual produzido pelas entrevistas será importado para o software Visual Qualitative Data Analysis (ATLAS.ti) e interpretado pela análise temática de conteúdo.

Metodologia Proposta:

Estudo de abordagem qualitativa fenomenológica, que será desenvolvido no cenário da Atenção Primária à Saúde/ESF do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A amostra será intencional. Serão convidados a participar do estudo os profissionais que atuam na ESF, incluindo as equipes de saúde bucal (ESB), nas nove US selecionadas do Distrito Sanitário Leste/Coordenadoria de Saúde Leste há pelo menos seis meses e que desempenham funções assistenciais no cotidiano do cuidado (agentes comunitários de saúde, auxiliares de saúde bucal, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem), além do gerente das US (seis gerentes nas nove US). Os dados serão produzidos por meio da realização de entrevistas individuais semiestruturadas, que serão gravadas por equipamento de áudio e transcritas na íntegra. O material textual produzido pelas entrevistas será importado para o software Visual Qualitative Data Analysis (ATLAS.ti) e interpretado pela análise temática de conteúdo.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Compreender o significado do trabalho em equipe, na percepção de profissionais que atuam na ESF.

Objetivo Secundário:

- Descrever e analisar características do trabalho em equipe.- Identificar potencialidades e desafios relacionados ao trabalho em equipe. - A partir dos resultados da pesquisa, construir artigo científico (produto bibliográfico) e como produto técnico, elaborar material didático sobre o processo de trabalho em equipe na ESF e desenvolver atividade de educação interprofissional com os profissionais.

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.783.901

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

O tempo de duração e o conteúdo da entrevista poderão causar algum tipo de desconforto aos (às) participantes. Se o (a) participante se sentir incomodado (a) ou desconfortável com a entrevista, pode parar de responder às perguntas a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo. As pesquisadoras, da mesma forma, podem interromper a entrevista se situações incômodas ou desconfortáveis aos (às) participantes forem percebidas. As pesquisadoras comprometem-se em evitar situações de exposição ou constrangimento pessoal e/ou coletivo durante as entrevistas, mantendo um ambiente cordial e respeitoso ao longo do encontro, sempre preservando o horário combinado com os (as) participantes. Os (As) participantes serão convidados a se manifestar na entrevista de forma espontânea. Outro risco do estudo consiste na quebra de sigilo e de confidencialidade dos dados. Para minimizar este risco, o nome dos participantes da pesquisa não será divulgado em qualquer meio e os dados originais da pesquisa serão utilizados somente pelas pesquisadoras envolvidas no estudo, sempre garantindo a privacidade e a confidencialidade.

Benefícios:

Por meio dos resultados encontrados na presente pesquisa será possível compreender como os profissionais da ESF percebem o trabalho em equipe no cotidiano de trabalho na APS, identificando aspectos facilitadores e barreiras que podem afetar o trabalho interprofissional.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Solicita-se, nesta emenda, a ampliação da amostra do estudo, a qual justifica-se pelo baixo número de profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF) na Unidade de Saúde (US) selecionada que aceitaram participar do estudo. Após a participação na reunião de equipe e explicação da pesquisa, foram convidados a participar do estudo todos os vinte e quatro profissionais (n=24) que atuam nesta US, entretanto, somente três profissionais demonstraram a intenção de participação. Na avaliação da equipe que está conduzindo a presente pesquisa, este número não conseguirá produzir os resultados esperados, o que justifica o adendo. Com a ampliação da amostra, ampliam-se, também, o número de US participantes do estudo (de uma para nove US localizadas no Distrito Leste da Coordenadoria de Saúde Leste de Porto Alegre). Buscando facilitar esta participação dos profissionais, entrevistas realizadas na modalidade remota, pelo Mconf da UFRGS, foram incluídas como possibilidade aos participantes de

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.783.901

pesquisa (<https://mconf.ufrgs.br/webconf/grupo-de-pesquisa-educacao-na-saude>). Tais entrevistas não terão gravação de imagem dos participantes, sendo gravadas por equipamento de áudio da pesquisadora. As alterações estão destacadas em vermelho no texto do projeto de pesquisa (Resumo, Metodologia, Cronograma e TCLE). Os demais aspectos do projeto seguem sem alterações.

As seguintes alterações foram realizadas no projeto

Pag 13: A Coordenadoria Leste é formada por quatro Distritos Sanitários de Saúde: Partenon, Lomba do Pinheiro, Leste e Nordeste. Ao todo, esses Distritos reúnem 44 US, das quais 38 são administradas pela Rede de Saúde da Divina Providência. Para a realização da pesquisa, serão selecionadas as Unidades de Saúde pertencentes ao Distrito Sanitário Leste, local de atuação da pesquisadora. Esse distrito é composto por 10 unidades: Clínica da Família Morro Santana, US Bom Jesus, US Jardim Carvalho, US Laranjeiras, US Mato Sampaio, US Milta Rodrigues, US Tijuca, US Vila Brasília, US Vila Jardim e US Vila Pinto. O estudo será realizado em nove US que compõem o Distrito Sanitário Leste, com exceção da US onde a pesquisadora atua (US Vila Jardim).

Pags 13 e 14:

A amostra será intencional (Turato, 2008). Serão convidados a participar do estudo os profissionais que atuam na ESF, incluindo as equipes de saúde bucal (ESB), nas nove US selecionadas do Distrito Sanitário Leste/Coordenadoria de Saúde Leste há pelo menos seis meses e que desempenham funções assistenciais no cotidiano do cuidado (agentes comunitários de saúde, auxiliares de saúde bucal, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem), além do gerente das US (seis gerentes nas nove US). As equipes dessas US são formadas por 146 profissionais. O tamanho final da amostra será definido pelo critério da saturação teórica (Fontanella et al., 2011) aliado à análise da densidade do material textual produzido.

Foram apresentados projeto de pesquisa e TCLE com alterações marcadas em vermelho no texto

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**



Continuação do Parecer: 7.783.901

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não foram observados óbices éticos nos documentos da emenda.

Diante do exposto, este CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação desta solicitação de emenda.

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2598811_É1.pdf	17/07/2025 20:53:14		Aceito
Outros	CartarespostaaoCEPjul2025.pdf	17/07/2025 20:51:50	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Outros	1_2025julhoCartadejustificativadeEmendaCEP.pdf	10/07/2025 13:36:23	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Folha de Rosto	6_FolhaDeRostoEMENDAassinado.pdf	10/07/2025 13:35:29	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Outros	5_SMS_Termo_de_Anuencia_Institucional_34545709.pdf	09/07/2025 20:59:42	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Outros	4_Aprovado_AdendoaoprojetodePesquisanaCompesqMedicina.pdf	09/07/2025 20:58:52	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	3_TERMOS DE CONSENTIMENTO_LIVRE_E_ESCLARECIDO.pdf	09/07/2025 20:58:02	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Brochura Pesquisa	2_2025julhoPROJETO_PPGENSAU_JESSICA ALTERADO.pdf	09/07/2025 20:57:50	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLErevisado.pdf	21/03/2025 13:24:02	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento /	TCLE_revisado_comdestaque.pdf	21/03/2025 07:23:08	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**



Continuação do Parecer: 7.783.901

Justificativa de Ausência	TCLE_revisado_comdestaque.pdf	21/03/2025 07:23:08	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_PPGENSAU_JESSICA_revisado_comdestaque.pdf	21/03/2025 07:22:28	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_PPGENSAU_JESSICA_revisado.pdf	21/03/2025 07:22:18	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA_PROJETO_PPGENSAU_JESSICA_revisado_comdestaque.pdf	21/03/2025 07:22:10	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA_PROJETO_PPGENSAU_JESSICA_revisado.pdf	21/03/2025 07:22:01	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Outros	CartarespostaaoCEPmar2025.pdf	20/03/2025 21:01:03	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Orçamento	ORCAMENTO_PROJETO_PPGENSAU_JESSICA.pdf	10/02/2025 20:49:48	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Outros	AprovacaoProjetodePesquisaComissaodePesquisadeMedicina.pdf	09/02/2025 17:42:23	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Outros	FORMULARIO_PROJETO_DE_PESQUISA_PMPAassinado.pdf	09/02/2025 17:41:42	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Declaração de concordância	SEI_PMPA31746978SMSTermodeAnuenciainstitucional.pdf	09/02/2025 17:39:46	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 21 de Agosto de 2025

Assinado por:
MARCIA HOLSBACH BELTRAME
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

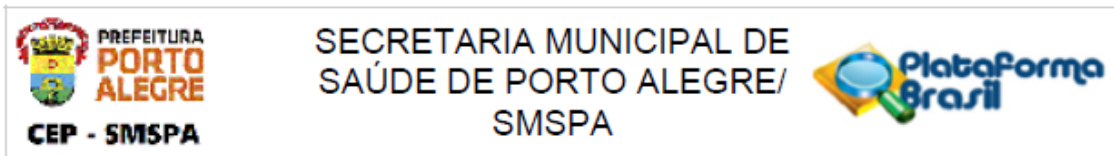
UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA, CEP SMS DE PORTO ALEGRE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituição Coparticipante

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: TRABALHO EM EQUIPE: SIGNIFICADO, POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Pesquisador: Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 86514325.2.3001.5338

Instituição Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.794.070

Apresentação do Projeto:

TRATA-SE DE EMENDA DE PESQUISA APROVADA EM 10/04/2025, PARECER CONSUBSTANCIADO 7.498.884.

Justificativa da emenda: Solicita-se, nesta emenda, a ampliação da amostra do estudo, a qual justifica-se pelo baixo número de profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF) na Unidade de Saúde (US) selecionada que aceitaram participar do estudo. Após a participação na reunião de equipe e explicação da pesquisa, foram convidados a participar do estudo todos os vinte e quatro profissionais (n=24) que atuam nesta US, entretanto, somente três profissionais demonstraram a intenção de participação. Na avaliação da equipe que está conduzindo a presente pesquisa, este número não conseguirá produzir os resultados esperados, o que justifica o adendo. Com a ampliação da amostra, ampliam-se, também, o número de US participantes do estudo (de uma para nove US localizadas no Distrito Leste da Coordenadoria de Saúde Leste de Porto Alegre). Buscando facilitar esta participação dos profissionais, entrevistas realizadas na modalidade remota, pelo Mconf da UFRGS, foram incluídas como possibilidade aos participantes de pesquisa (<https://mconf.ufrgs.br/webconf/grupo-de-pesquisa-educacao-na-saude>). Tais entrevistas não terão gravação de imagem dos

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro	Centro Histórico	CEP:	90.010-040
UF:	RS	Município	PORTO ALEGRE
Telefone	(51)3289-5517	Fax:	(51)3289-2453
		E-	cep_sms@hotmail.com



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSPA



Continuação do Parecer: 7.794.070

participantes, sendo gravadas por equipamento de áudio da pesquisadora. As alterações no projeto e TCLE estão destacadas em vermelho no texto do projeto de pesquisa. Os demais aspectos do projeto seguem sem alterações.

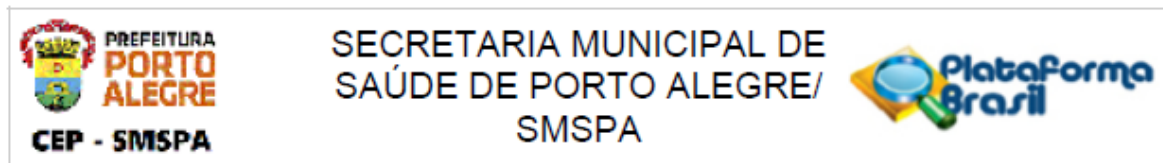
Resumo:

INTRODUÇÃO: O trabalho em equipe é visto como uma ferramenta essencial para a promoção de cuidados integrados e resolutivos, sendo uma estratégia-chave para alcançar a integralidade no Sistema Único de Saúde (SUS). **OBJETIVO:** Compreender o significado do trabalho em equipe na percepção de profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF). **METODOLOGIA:** Estudo de abordagem qualitativa fenomenológica, que será desenvolvido no cenário da Atenção Primária à Saúde/ESF do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A amostra será intencional. Serão convidados a participar do estudo profissionais que atuam em uma das Unidades de Saúde da Coordenadora Leste de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil (n=24). Serão excluídos da amostra, profissionais que mudem de lotação, ou que estejam em férias/licença ou outro motivo de afastamento no período da coleta de dados. Os dados serão produzidos por meio da realização de entrevistas individuais semiestruturadas, que serão gravadas por equipamento de áudio e transcritas na íntegra. O material textual produzido pelas entrevistas será importado para o software Visual Qualitative Data Analysis (ATLAS.ti) e interpretado pela análise temática de conteúdo. **PRODUTO TÉCNICO:** Será produzido artigo com os resultados da pesquisa, em periódico da área da Saúde Coletiva (produto bibliográfico) e material didático sobre o tema do trabalho em equipe na ESF (produto técnico) e desenvolvimento de atividade de educação interprofissional com profissionais da ESF (produto técnico). **RESULTADOS ESPERADOS:** Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir com a produção de evidências qualitativas sobre o significado do trabalho em equipe na ESF e com sua qualificação, trazendo a compreensão de aspectos facilitadores e desafios.

Hipótese:

O modo como os profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) percebem o trabalho em equipe reflete sua formação e sua forma de trabalho na

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar
Bairro Centro Histórico **CEP:** 90.010-040
UF: RS **Município** PORTO ALEGRE
Telefone (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453 **E-** cep_sms@hotmail.com



Continuação do Parecer: 7.794.070

equipe, com outros profissionais, o que afeta suas práticas de cuidado em saúde.

Metodologia Proposta:

Estudo de abordagem qualitativa fenomenológica, que será desenvolvido no cenário da Atenção Primária à Saúde/ESF do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A amostra será intencional. Serão convidados a participar do estudo os profissionais que atuam na ESF, incluindo as equipes de saúde bucal (ESB), nas nove US selecionadas do Distrito Sanitário Leste/Coordenadoria de Saúde Leste há pelo menos seis meses e que desempenham funções assistenciais no cotidiano do cuidado (agentes comunitários de saúde, auxiliares de saúde bucal, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem), além do gerente das US (seis gerentes nas nove US). Os dados serão produzidos por meio da realização de entrevistas individuais semiestruturadas, que serão gravadas por equipamento de áudio e transcritas na íntegra. O material textual produzido pelas entrevistas será importado para o software Visual Qualitative Data Analysis (ATLAS.ti) e interpretado pela análise temática de conteúdo.

Metodologia de Análise de Dados:

O material textual produzido nas entrevistas será importado para o software Visual Qualitative Data Analysis (ATLAS.ti). Com o auxílio do software, os dados serão interpretados pela estratégia da análise temática de conteúdo (Bardin, 2011), sendo organizados em categorias emergentes de análise para facilitar a compreensão das ideias e posterior discussão.

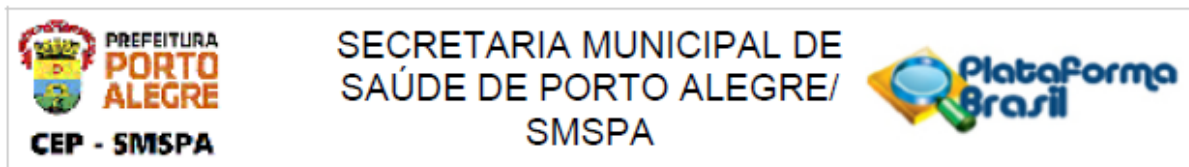
Desfecho Primário:

Obter resultados que tragam a compreensão do significado do trabalho em equipe, na percepção de profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF).

Desfecho Secundário:

Obter resultados que:- Descrevam e analisem características do trabalho em equipe.- Identifiquem potencialidades e desafios relacionados ao trabalho em equipe. - Possibilitem a construção de artigo científico (produto bibliográfico) e como produto técnico, de material didático sobre o processo de trabalho em equipe na ESF e desenvolver atividade de educação

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro	Centro Histórico	CEP:	90.010-040
UF:	RS	Município	PORTO ALEGRE
Telefone	(51)3289-5517	Fax:	(51)3289-2453
E-	cep_sms@hotmail.com		



Continuação do Parecer: 7.794.070

interprofissional com os profissionais.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Compreender o significado do trabalho em equipe, na percepção de profissionais que atuam na ESF.

Objetivo Secundário:- Descrever e analisar características do trabalho em equipe.- Identificar potencialidades e desafios relacionados ao trabalho em equipe. - A partir dos resultados da pesquisa, construir artigo científico (produto bibliográfico) e como produto técnico, elaborar material didático sobre o processo de trabalho em equipe na ESF e desenvolver atividade de educação interprofissional com os profissionais.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

O tempo de duração e o conteúdo da entrevista poderão causar algum tipo de desconforto aos (às) participantes. Se o (a) participante se sentir incomodado (a) ou desconfortável com a entrevista, pode parar de responder às perguntas a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo. As pesquisadoras, da mesma forma, podem interromper a entrevista se situações incômodas ou desconfortáveis aos (às) participantes forem percebidas. As pesquisadoras comprometem-se em evitar situações de exposição ou constrangimento pessoal e/ou coletivo durante as entrevistas, mantendo um ambiente cordial e respeitoso ao longo do encontro, sempre preservando o horário combinado com os (as) participantes. Os (As) participantes serão convidados a se manifestar na entrevista de forma espontânea. Outro risco do estudo consiste na quebra de sigilo e de confidencialidade dos dados. Para minimizar este risco, o nome dos participantes da pesquisa não será divulgado em qualquer meio e os dados originais da pesquisa serão utilizados somente pelas pesquisadoras envolvidas no estudo, sempre garantindo a privacidade e a confidencialidade.

Benefícios:

Por meio dos resultados encontrados na presente pesquisa será possível compreender como os profissionais da ESF percebem o trabalho em equipe no cotidiano de trabalho na APS, identificando aspectos facilitadores e barreiras

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro	Centro Histórico	CEP:	90.010-040
UF:	RS	Município	PORTO ALEGRE
Telefone	(51)3289-5517	Fax:	(51)3289-2453
E-	cep_sms@hotmail.com		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSPA



Continuação do Parecer: 7.794.070

que podem afetar o trabalho interprofissional.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Projeto de pesquisa apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de mestre no Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde e Mestrado Profissional, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de JÉSSICA RODRIGUEZ STREY.

Orientador (a): Profa. Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi

Tamanho da Amostra no - 146

Propõe dispensa do TCLE? Não

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Documentos apresentados correspondem ao necessario para desenvolver o Projeto

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

A emenda ao projeto de pesquisa está apta para aprovação, não havendo óbices éticos para a sua realização.

Considerações Finais a critério do CEP:

A emenda analisada neste parecer está em conformidade com o protocolo de pesquisa original. Seu prosseguimento, nestes termos, está aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Outros	CartarespostaaocEPjul2025.pdf	17/07/2025 20:51:50	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Outros	1_2025julhoCartadejustificativadeEmendaCEP.pdf	10/07/2025 13:36:23	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Outros	5_SMS_Termo_de_Anuencia_Institucional_34545709.pdf	09/07/2025 20:59:42	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Outros	4_Aprovado_AdendoaoprojetodePesquisanaCompesqMedicina.pdf	09/07/2025 20:58:52	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	3_TERMÔ DE CONSENTIMENTO_LIVRE_E_ESCLARECIDO.pdf	09/07/2025 20:58:02	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Brochura Pesquisa	2_2025julhoPROJETO_PPGENSAU_JÉSSICA ALTERADO.pdf	09/07/2025 20:57:50	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro Centro Histórico

CEP: 90.010-040

UF: RS

Município

PORTO ALEGRE

Telefone (51)3289-6517

Fax: (51)3289-2453

E-

cep_sms@hotmail.com

 PREFEITURA PORTO ALEGRE CEP - SMSPA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE/ SMSPA	
---	---	---

Continuação do Parecer: 7.794.070

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLErevisado.pdf	21/03/2025 13:24:02	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_revisado_comdestaque.pdf	21/03/2025 07:23:08	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_PPGENSAU_JESSICA_revisado_comdestaque.pdf	21/03/2025 07:22:28	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_PPGENSAU_JESSICA_revisado.pdf	21/03/2025 07:22:18	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Outros	CartarespostaaoCEPmar2025.pdf	20/03/2025 21:01:03	Jéssica Rodriguez Strey	Aceito
Outros	AprovacaoProjetodePesquisaComissaodePesquisadeMedicina.pdf	09/02/2025 17:42:23	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito
Outros	FORMULARIO_PROJETO_DE_PESQUISA PMPA assinado.pdf	09/02/2025 17:41:42	Ramona Fernanda Ceriotti Toassi	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 26 de Agosto de 2025

Assinado por:
Alexandre Luis da Silva Ritter
 (Coordenador(a))

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar			
Bairro	Centro Histórico	CEP:	90.010-040
UF:	RS	Município	PORTO ALEGRE
Telefone	(51)3289-5517	Fax:	(51)3289-2453
E-	cep_sms@hotmail.com		

APÊNDICE A – CRITÉRIOS COREQ

Critérios consolidados para relatar pesquisa qualitativa			
Nº do item	Tópico	Perguntas/Descrição do guia	Respostas do estudo
Domínio 1: Equipe de pesquisa e reflexividade			
Características pessoais			
1	Entrevistador/facilitador	Qual autor (autores) conduziu a entrevista ou o grupo focal?	Pesquisadora principal (mestranda) (p. 25)
2	Credenciais	Quais eram as credenciais do pesquisador? Exemplo: PhD, médico.	Cirurgiã-dentista. Especialista em Estomatologia (Residência Integrada em Saúde Bucal com ênfase em Estomatologia). Especialista em Saúde Pública. Mestranda do PPG EnSau (p. 8)
3	Ocupação	Qual a ocupação desses autores na época do estudo?	Cirurgiã-dentista na ESF do estudo (p. 8)
4	Gênero	O pesquisador era do sexo masculino ou feminino?	Feminino
5	Experiência e treinamento	Qual a experiência ou treinamento do pesquisador?	A pesquisadora passou por treinamento prévio para a realização das entrevistas (p. 25)
Relacionamento com os participantes			
6	Relacionamento estabelecido	Foi estabelecido um relacionamento antes do início do estudo?	Sim, a pesquisadora principal, mestranda, trabalha em ESF da Coordenadoria de Saúde em que foi realizado o estudo (p. 24)
7	Conhecimento do participante sobre o entrevistador	O que os participantes sabiam sobre o pesquisador? Por exemplo: objetivos pessoais, razões para desenvolver a pesquisa.	Conheciam a pesquisadora como colega de trabalho vinculada a mesma Coordenadoria de Saúde e sabiam se tratar de um estudo de Mestrado Profissional.
8	Características do entrevistador	Quais características foram relatadas sobre o entrevistador/facilitador? Por exemplo, preconceitos, suposições, razões e interesses no tópico da pesquisa.	Pesquisadora mestranda, com interesse em desenvolver seu estudo de pós-graduação (Mestrado Profissional).
Domínio 2: Conceito do estudo			
Estrutura teórica			
9	Orientação metodológica e teoria	Qual orientação metodológica foi declarada para sustentar o estudo? Por exemplo: teoria fundamentada, análise do discurso, etnografia, fenomenologia e análise de conteúdo.	Fenomenologia da percepção (p. 23)
Seleção de participantes			

10	Amostragem	Como os participantes foram selecionados? Por exemplo: conveniência, consecutiva, amostragem, bola de neve.	Amostra intencional por saturação (p. 24 e 25)
11	Método de abordagem	Como os participantes foram abordados? Por exemplo: pessoalmente, por telefone, carta ou e-mail.	Em reuniões de equipe e individualmente, por aplicativo de mensagem instantânea (p. 24)
12	Tamanho da amostra	Quantos participantes foram incluídos no estudo?	13 (p. 28)
13	Não participação	Quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram? Por quais motivos?	Não houve recusa, mas houve uma desistência (confirmou, mas não compareceu à entrevista e não entrou mais em contato)
Cenário			
14	Cenário da coleta de dados	Onde os dados foram coletados? Por exemplo: na casa, na clínica, no local de trabalho	No local de trabalho (ESF) dos participantes ou de forma remota (p. 24)
15	Presença de não participantes	Havia mais alguém presente além dos participantes e pesquisadores?	Não
16	Descrição da amostra	Quais são as características importantes da amostra? Por exemplo: dados demográficos, data da coleta.	Dados demográficos e de formação apresentados no Quadro 3 (p. 28) A coleta de dados realizada entre junho de 2025 e janeiro de 2026 (p. 25)
Coleta de dados			
17	Guia da entrevista	Os autores forneceram perguntas, instruções, guias? Elas foram testadas por teste-piloto?	Sim. A pesquisa teve um roteiro de entrevistas previamente estabelecido (p. 25)
18	Repetição de entrevistas	Foram realizadas entrevistas repetidas? Se sim, quantas?	Não
19	Gravação audiovisual	A pesquisa usou gravação de áudio ou visual para coletar os dados?	Sim. Aplicativo gravador em <i>smartphone</i> (p. 25)
20	Notas de campo	As notas de campo foram feitas durante e/ou após a entrevista ou o grupo focal?	Após, para a organização da pesquisadora, mas não foram analisadas como resultado
21	Duração	Qual a duração das entrevistas ou do grupo focal?	Duração média de 35 minutos (p. 25)
22	Saturação de dados	A saturação de dados foi discutida?	Sim. Discutiu-se a saturação junto a densidade do material textual produzido (p. 25)
23	Devolução de transcrições	As transcrições foram devolvidas aos participantes para comentários e/ou correção?	Sim, foram devolvidas (p. 26)
Domínio 3: Análise e resultados			
24	Número de codificadores de dados	Quantos foram os codificadores de dados?	Uma pesquisadora
25	Descrição da árvore de codificação	Os autores forneceram uma descrição da árvore de codificação?	Sim, no formato de Quadro (p. 29)

26	Derivação de temas	Os temas foram identificados antecipadamente ou derivados dos dados?	Derivados dos dados
27	<i>Software</i>	Qual <i>software</i> , se aplicável, foi usado para gerenciar os dados?	<i>Software</i> Atlas.ti (p. 26)
28	Verificação do participante	Os participantes forneceram <i>feedback</i> sobre os resultados?	Sim, após a defesa da Dissertação
Relatório			
29	Citações apresentadas	As citações dos participantes foram apresentadas para ilustrar os temas/achados? Cada citação foi identificada? Por exemplo, pelo número do participante.	Sim. Para preservar a identificação dos participantes da pesquisa, os relatos produzidos pelas entrevistas foram identificados de modo codificado pela letra P (profissional) seguida por números sequenciais (Entrevista P1, P2, P3, ...), que não correspondem necessariamente à ordem em que foram entrevistados (p. 26)
30	Dados e resultados consistentes	Houve consistência entre os dados apresentados e os resultados?	Sim
31	Identificação dos principais temas	Os principais temas foram apresentados nos resultados?	Sim
32	Identificação de temas secundários	Há descrição dos diversos casos ou discussão dos temas secundários?	Temas secundários sim. Há uma subcategoria apresentada nos resultados (p. 29)

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA

Você está participando de uma pesquisa que trata do tema trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família. Vamos conversar sobre sua percepção em relação ao trabalho em equipe na Unidade de Saúde a qual você faz parte. Para compreender como se dá o processo de trabalho e as relações interprofissionais, o relato da sua experiência, tal como ela é, será fundamental para este estudo. Fique à vontade para responder e não se preocupe, pois sua identidade será totalmente preservada.

PESQUISA: TRABALHO EM EQUIPE

Data: ____/____/202 __. Entrevista P (____).

DADOS DE CONTEXTO DO PARTICIPANTE

1. Gênero:
2. Idade:
3. Profissão:
4. Escolaridade
 - () Curso técnico
 - () Educação Superior
 - () Pós-graduação (em andamento). Se sim, qual?
 - () Pós-graduação (concluída). Se sim, qual?
5. Ano de conclusão:
6. Tempo de atuação na APS (em meses ou anos):
7. Tempo de atuação na Unidade de Saúde da Família relacionada ao estudo (em meses ou anos): ____ () meses () anos

SOBRE O TRABALHO EM EQUIPE

1. Em sua formação profissional (desde a graduação) você teve experiência de aprendizagem com outros núcleos profissionais? (lembra de atividades compartilhadas com estudantes de outras profissões da saúde. Se sim, poderia falar sobre tais atividades).
2. Se sim, comente se tal aprendizagem fez diferença no seu trabalho com outras profissões.
3. Após sua formação você participou de algum curso, capacitação ou conferência sobre o tema da interprofissionalidade ou que possibilitou a interação com outras profissões?

4. Você se sentiu preparado para trabalhar em equipe, com diferentes profissões da saúde, após a sua formação?
5. Poderia descrever como se dá o processo de trabalho da equipe em que atua?
6. Quais elementos você considera essenciais para que o trabalho em equipe aconteça? (comunicação, confiança, divisão de tarefas, liderança, etc.)
7. Você consegue identificar momentos no seu trabalho em que aprendeu e/ou trabalhou em conjunto com outros colegas e que esta interação promoveu melhorias no processo de cuidado às pessoas-famílias? Pode dar exemplos?
8. Você vê sentido em compartilhar aprendizados do seu núcleo com outro profissional da equipe? Pode explicar?
9. Qual a sua percepção sobre o trabalho em equipe? Você considera que o trabalho em equipe é importante para a qualidade do atendimento prestado aos usuários? Pode falar sobre isso?
10. Como você percebe o papel de cada profissional no cotidiano do trabalho em equipe? (falar sobre as responsabilidades de cada profissional)
11. As diferentes categorias profissionais (enfermeiros, médicos, agentes comunitários, etc.) interagem no contexto do trabalho em equipe? Você percebe que todos os membros da equipe participam da tomada de decisões no trabalho?
12. Percebe ou já percebeu a existência de conflitos na equipe? Como são resolvidos?
13. Existem reuniões ou outros momentos formais para discussão de casos e planejamento de ações em equipe? Como elas funcionam?
14. Fale sobre a comunicação entre os membros da equipe. Percebe barreiras nessa comunicação?
15. Quais são os aspectos da equipe ou do ambiente de trabalho que facilitam e contribuem para o desenvolvimento do trabalho em equipe na ESF?
16. Como percebe os desafios enfrentados no dia a dia para que o trabalho em equipe aconteça?
17. Percebe situações em que o trabalho em equipe é mais difícil de ser implementado? Fale sobre essas situações.
18. Na sua percepção, o que poderia ser feito para qualificar o trabalho em equipe na ESF? Considera que a equipe se beneficiaria com uma formação sobre o trabalho em equipe interprofissional e práticas colaborativas em saúde? Seria uma ação de educação permanente viável?
19. Gostaria de acrescentar informações à entrevista? (faltou falar sobre/gostaria de falar mais sobre).

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), na pesquisa científica intitulada TRABALHO EM EQUIPE: SIGNIFICADO, POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua colaboração é muito importante, mas a decisão em participar deve ser sua. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em decidir. Para que você possa participar desta pesquisa, seu consentimento por escrito é necessário e nenhum procedimento do estudo será realizado antes de você assinar este documento. Se você concordar em participar da pesquisa basta preencher os seus dados e assinar esse Termo de Consentimento, que está em duas vias (uma delas fica com você e a outra com a pesquisadora). Se você tiver alguma dúvida poderá conversar com a pesquisadora responsável pela pesquisa.

Antes de você decidir se deseja participar desta pesquisa, você receberá explicações sobre o que o estudo envolve e seu objetivo. O presente estudo trata do tema do trabalho em equipe e tem o objetivo de analisar como os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) percebem o processo de trabalho em equipe.

Se você concordar em fazer parte deste estudo, deverá participar de uma entrevista individual, com tempo estimado de 40 minutos, em uma sala reservada e silenciosa da Unidade de Saúde em que atua, evitando qualquer constrangimento e exposição desnecessária. Data e horário serão previamente combinados, não interferindo no andamento do meu processo de trabalho e nem no atendimento aos usuários. A entrevista será guiada por um roteiro com sete (7) questões iniciais a respeito do contexto do participante – gênero, idade, profissão, escolaridade, tempo de atuação na APS, tempo de atuação na Unidade de Saúde relacionada ao estudo - e 19 questões abertas sobre o tema da pesquisa (trabalho em equipe). Se você concordar, a entrevista será gravada em gravador de voz digital e posteriormente transcrita na íntegra, em formato de texto, em programa de computador e que somente as pesquisadoras envolvidas nesse estudo conhecerão os conteúdos para posteriormente discutir os resultados. As transcrições serão devolvidas a você para comentários e/ou correção. As gravações da

Rubrica do pesquisador:

Rubrica do participante da pesquisa:

Página 1 de 4

entrevista ficarão armazenadas em um HD externo específico, sob responsabilidade do pesquisador, sem acesso de terceiros, por um período de cinco (5) anos e após, serão destruídas. O material textual das entrevistas será utilizado somente para este estudo, não sendo usado em estudos futuros. As pesquisadoras estarão submetidas às normas do sigilo profissional.

Sua participação não terá nenhum custo/despesa e você não receberá qualquer vantagem ou remuneração financeira. A assinatura deste termo não exclui a possibilidade de buscar indenização diante de eventuais danos decorrentes de sua participação na pesquisa.

Você receberá resposta a qualquer pergunta ou explicação acerca dos assuntos relacionados a esta pesquisa, possíveis dúvidas acerca dos procedimentos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa.

Sua participação é voluntária e terá a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo para a sua vida pessoal e profissional.

Você não será identificado (a) quando da divulgação dos resultados do estudo e as informações produzidas pela pesquisa serão utilizadas somente para fins científicos do presente estudo.

Por meio dos resultados encontrados na presente pesquisa será possível compreender como os profissionais da ESF percebem o trabalho em equipe, identificando aspectos facilitadores e desafios que afetam o cotidiano do serviço relacionado ao trabalho em equipe, qualificando-o permanentemente (benefícios).

Considerando que toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados, nesta pesquisa, o tempo de duração e o conteúdo da entrevista poderão lhe causar algum tipo de desconforto. Se você se sentir incomodado (a) ou desconfortável com a entrevista, pode parar de responder às perguntas a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo. As pesquisadoras, da mesma forma, podem interromper a entrevista se situações incômodas ou desconfortáveis aos (às) participantes forem percebidas. As pesquisadoras comprometem-se em evitar situações de exposição ou constrangimento pessoal e/ou coletivo durante as entrevistas, mantendo um ambiente cordial e respeitoso ao longo do encontro, sempre preservando o horário combinado. Como participante, você será convidado a se

Rubrica do pesquisador:

Rubrica do participante da pesquisa:

Página 2 de 4

manifestar na entrevista de forma espontânea. Outro risco do estudo consiste na quebra de sigilo e de confidencialidade dos dados. Para minimizar este risco, seu nome não será divulgado em qualquer meio e os dados originais da pesquisa serão utilizados somente pelas pesquisadoras envolvidas no estudo, sempre garantindo a privacidade e a confidencialidade.

O projeto foi avaliado por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar, emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição.

Se houver dúvidas quanto às questões éticas do estudo, pode entrar em contato com o CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Avenida Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.040-060, telefone (51) 3308-3787, e-mail etica@gabinete.ufrgs.br, de segunda a sexta, das 08:00 as 12:00 e 13h30min as 17h30min. E com o CEP da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMSPA), Rua Capitão Montanha, 27, 6º andar, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-040, e-mail cep_sms@hotmail.com.

As pesquisadoras estarão à disposição para qualquer explicação que considerem necessária em qualquer etapa da pesquisa (Professora Ramona Fernanda Ceriotti Toassi - pesquisadora responsável, telefone (51) 98178-5269, endereço Rua Ramiro Barcelos 2492, e-mail ramona.fernanda@ufrgs.br, e Jéssica Rodriguez Strey, cirurgiã-dentista mestranda, telefone (51) 99266-6270, e-mail streyjessica@gmail.com).

Li e compreendi os objetivos e a relevância da pesquisa, a forma como ocorrerá a minha participação, os procedimentos, os riscos e os benefícios decorrentes deste estudo, antes de manifestar meu consentimento.

Porto Alegre, _____ de _____ de 202_.

Assinatura do (a) participante de pesquisa: _____

Assinatura da pesquisadora responsável: _____

Assinatura da pesquisadora mestranda: _____

Rubrica do pesquisador:

Rubrica do participante da pesquisa:

Página 3 de 4

APÊNDICE D – PRODUTO TÉCNICO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde

Jéssica Rodriguez Strey (UFRGS)
Ramona Ceriotti Toassi (UFRGS)

Trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família:
significado, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação

1ª edição

UFRGS
Porto Alegre
2026

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Reitora: Profa. Marcia Cristina Bernardes Barbosa
Vice-Reitor: Prof. Pedro de Almeida Costa

Pró-Reitoria de Graduação: Profa. Nády Pesce da Silveira
Pró-Reitoria de Pós-Graduação: Profa. Claudia Wasserman
Pró-Reitoria de Pesquisa: Prof. Flavio Pereira Kapczinski
Pró-Reitoria de Extensão: Profa. Daniela Borges Pavani
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração: Prof. Diogo Joel Demarco
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: Arthur Gustavo dos Santos Bloise
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis: Profa. Natalia Pietra Mendez

Faculdade de Medicina

Diretora: Profa. Cristiane Bauermann Leitão
Vice-Diretor: Prof. Leandro Meirelles Nunes

Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde

Coordenadora: Profa. Camila Giugliani
Coordenadora substituta: Profa. Cristine Maria Warmling

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

U58l Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde [recurso eletrônico]
Trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família: significado, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação / Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde; Jéssica Rodriguez Strey e Ramona Ceriotti Toassi – Porto Alegre: UFRGS/FAMED/PPGENSAU, 2026.

17p.

ISBN eletrônico: 978-65-02-19267-2

1. Relatório Técnico 2. Estratégias de Saúde Nacionais 3. Saúde da Família 4. Pessoal de Saúde I. Faculdade de Medicina II. Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde III. Strey, Jéssica Rodriguez IV. Toassi, Ramona Ceriotti V. Título

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
Biblioteca FAMED/HCPA

SUMÁRIO

DETALHAMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO	04
APRESENTAÇÃO DA PESQUISA	05
RESULTADOS DA PESQUISA	07
Perfil dos participantes de pesquisa	07
Trabalho em equipe na formação do profissional da saúde	07
O significado do trabalho em equipe na percepção de profissionais da ESF	08
Facilitadores do trabalho em equipe na ESF	10
Desafios do trabalho em equipe na ESF	10
Estratégias para qualificar o trabalho em equipe na ESF	11
CONCLUSÃO	12
Possibilidades de aplicação no contexto da ESF	12
DOCUMENTOS RECOMENDADOS	14
REFERÊNCIAS	15

DETALHAMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO

O Quadro 1 sintetiza as informações que caracterizam o relatório técnico apresentado neste documento.

Quadro 1 – Quadro síntese do relatório técnico conclusivo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Relatório técnico conclusivo (Eixo 4: Serviços técnicos)
FINALIDADE DO PRODUTO	Desenvolver relatório técnico sobre trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família (ESF), apresentando os principais achados da pesquisa desenvolvida como trabalho final (Dissertação) do Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde – Mestrado Profissional, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O relatório também traz recomendações para o fortalecimento do trabalho colaborativo interprofissional nas equipes da ESF
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Boa saúde e bem-estar Educação de qualidade
PÚBLICO DE INTERESSE	Equipe gestora das Coordenadorias de Saúde de Porto Alegre (Norte, Sul, Leste e Oeste) Gestores e profissionais da ESF
NATUREZA DO PRODUTO	Documento eletrônico (formato pdf)
AVANÇOS TECNOLÓGICOS/ GRAU DE NOVIDADE	Produto com médio teor inovativo: combinação de conhecimentos pré-estabelecidos
DIVULGAÇÃO DO PRODUTO	Repositório Digital da UFRGS – LUME Página do PPG EnSau <i>ResearchGate</i>
APLICABILIDADE/ REPLICABILIDADE DO PRODUTO TÉCNICO	A produção possui potencial para uma alta aplicabilidade no município onde o estudo foi realizado. Como ficará disponível no LUME, pode ser aplicado em novos contextos
PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PRODUTO	Trabalho em equipe: significado, potencialidades e desafios na percepção de profissionais da Estratégia Saúde da Família (nº 46833)
OBJETIVO DO PROJETO DE PESQUISA VINCULADO AO PRODUTO	Compreender o significado do trabalho em equipe, identificando aspectos da formação, facilitadores, desafios e estratégias de qualificação, na percepção de profissionais que atuam na ESF
LINHA DE PESQUISA VINCULADA AO PRODUTO	Processos de Ensino na Saúde
SETOR DA SOCIEDADE BENEFICIADO PELO PRODUTO	Saúde/Estratégia Saúde da Família
ÁREA IMPACTADA PELO PRODUTO	Saúde Coletiva
DISCENTE DO MESTRADO PROFISSIONAL AUTORA	Cirurgiã-dentista Jéssica Rodriguez Strey
DOCENTE PERMANENTE DO MESTRADO PROFISSIONAL AUTORA	Profa. Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi
FONTE DE FINANCIAMENTO	Recursos próprios

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

No contexto do trabalho em saúde, o trabalho em equipe constitui-se como uma forma de trabalho coletivo desenvolvida a partir das relações entre profissionais de diferentes áreas, por meio de suas interações e intervenções no cotidiano dos serviços, visando à integração das ações no cuidado (Peduzzi *et al.*, 2013; Escalda; Parreira, 2018). Trabalhar em equipe configura-se como componente estratégico essencial para lidar com a crescente complexidade das demandas em saúde, contribuindo para a qualidade da atenção, a satisfação dos profissionais e a efetividade do cuidado prestado (Peduzzi *et al.*, 2020; Ogata *et al.*, 2021; Kanno *et al.*, 2023).

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem papel central na reorganização da atenção primária, orientando-se pela integralidade do cuidado e pela atuação interdisciplinar das equipes (Garcia *et al.*, 2015). Contudo, a simples presença de diferentes profissionais em um mesmo serviço não garante a efetivação do trabalho em equipe, sendo necessária a construção de práticas colaborativas baseadas na comunicação, na articulação de saberes e no compartilhamento de responsabilidades (Peduzzi, 2016).

Nesse cenário, persistem desafios relacionados à formação profissional, ainda predominantemente centrada em modelos uniprofissionais, bem como dificuldades na interação entre os diferentes núcleos de saber e nas condições de organização do trabalho, que podem comprometer a integralidade do cuidado e favorecer práticas fragmentadas (Frenk *et al.*, 2010; Costa, 2016; Frenk *et al.*, 2022).

Diante dessa problemática, foi realizada pesquisa vinculada à Mestrado Profissional no Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), orientado pela seguinte questão de pesquisa: como os profissionais que atuam na ESF percebem o significado do trabalho/trabalhar em equipe, considerando facilitadores, desafios e estratégias de qualificação no contexto da prática cotidiana?

O estudo propôs-se a compreender o significado do trabalho em equipe, identificando aspectos relacionados à formação profissional, aos facilitadores, aos desafios e às estratégias de qualificação, a partir da percepção de profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família do município de Porto Alegre. Foi desenvolvido no Distrito Sanitário Leste, pertencente à Coordenadoria de Saúde Leste do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, abrangendo Unidades de Saúde administradas, no período da realização do estudo, pela Organização da Sociedade Civil Rede de Saúde da Divina Providência (RSDP).

Tratou-se de estudo qualitativo de abordagem fenomenológica (fenomenologia da percepção – Merleau-Ponty, 2006). Os dados foram produzidos por meio da realização de entrevistas individuais semiestruturadas com profissionais de diferentes núcleos da ESF, e analisados pela técnica de análise de conteúdo (unidades temáticas/categorias e subcategorias – Bardin, 2011) com suporte do *software* ATLAS.ti. A pesquisa foi autorizada pela coordenação da Coordenadoria de Saúde em que foi realizada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS (CAAE nº 86514325.2.0000.5347/Parecer no 7.783.901) e da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (CAAE nº 86514325.2.3001.5338/Parecer nº 7.794.070).

Este relatório técnico apresenta, de forma sintética e orientada à prática, os principais achados da investigação, com foco na aplicabilidade dos resultados para a qualificação de práticas colaborativas e para o fortalecimento da gestão do trabalho em saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde/ESF de Porto Alegre.

RESULTADOS DA PESQUISA

• Perfil dos participantes da pesquisa

Participaram do estudo 13 profissionais com atuação na equipe da ESF de uma das coordenadorias de saúde de Porto Alegre (amostra intencional por saturação), sendo quatro cirurgiões-dentistas, três enfermeiros, dois agentes comunitários de saúde, dois gerentes, um médico e um técnico de Enfermagem. Os profissionais eram em sua maioria mulheres, com idade que variou de 27 a 55 anos. A residência e a especialização foram as pós-graduações mais frequentes no grupo pesquisado. O tempo de trabalho no SUS/ESF variou de três a 22 anos e na Unidade de Saúde em que atuavam de um mês a 13 anos.

• Trabalho em equipe na formação do profissional da saúde

Os participantes do estudo relataram pouca ou nenhuma vivência de educação e trabalho interprofissional durante a graduação, evidenciando a predominância de um modelo de ensino uniprofissional, centrado nos saberes específicos de cada área. Quando existentes, as experiências envolvendo outras profissões da saúde limitavam-se ao compartilhamento de espaços físicos, sem interação real entre os cursos.

As residências uniprofissionais e multiprofissionais foram identificadas como importantes espaços de aprendizado compartilhado, sendo descritas como o momento em que os profissionais desenvolveram competências para o trabalho em equipe. Os estágios práticos nos serviços, a discussão de casos com outros núcleos e a vivência no SUS foram os elementos que contribuíram para uma maior segurança para atuar de forma colaborativa. Para os que não realizaram residência, essa segurança foi construída ao longo da rotina de trabalho e na vivência profissional.

Os profissionais sinalizaram a ausência de capacitações voltadas ao tema trabalho em equipe nas USs, bem como a falta de incentivo à aprendizagem no trabalho, indicando que as formações disponíveis são predominantemente técnicas e pontuais.

• O significado do trabalho em equipe na percepção de profissionais da ESF

O trabalho/trabalhar em equipe foi compreendido pelos profissionais da ESF como elemento central para a produção de um cuidado integral e resolutivo, sendo descrito como indispensável para o funcionamento das Unidades de Saúde. A atuação conjunta dos diferentes

núcleos profissionais com seus conhecimentos específicos, sem sobreposição ou hierarquização das profissões, foi reconhecida como condição para um trabalho em equipe que possa responder à complexidade das demandas em saúde, a partir da complementaridade de saberes e da construção compartilhada dos planos de cuidado. O profissional enfermeiro foi visto como uma liderança responsável pela organização da equipe e referência nos atendimentos compartilhados.

A efetividade do trabalho em equipe foi diretamente relacionada à qualidade da comunicação interprofissional. A comunicação foi apontada como essencial para qualificar as relações interpessoais e para a constituição do trabalho colaborativo em equipe, envolvendo processos de escuta, diálogo, troca de informações e tomada de decisão conjunta. Além disso, foi reconhecida como principal estratégia para a resolução de conflitos e alinhamento das ações entre os profissionais, especialmente em contextos de divergência ou sobrecarga de trabalho.

Entendendo CONCEITOS

Educação Interprofissional (EIP) “ocorre quando os membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou a saúde/bem-estar dos usuários”.

(Reeves *et al.*, 2013, p. 2)

EIP: estratégia educacional essencial para aprimorar o trabalho em equipe e desenvolver competências colaborativas.

(Organização Mundial da Saúde, 2010; Peduzzi *et al.*, 2013; Ely; Toassi, 2018; Freire Filho *et al.*, 2019; Souza; Ely; Toassi, 2022; Toassi *et al.*, 2026)

Trabalho Interprofissional (TIP): busca a colaboração entre profissionais de diferentes áreas da saúde, pela articulação de distintos saberes com o objetivo de melhorar a prática clínica e os resultados de saúde. Por meio da integração interprofissional, a equipe promove uma abordagem coordenada e eficiente do cuidado, com impacto positivo na qualidade dos serviços prestados, além de favorecer uma visão crítica sobre suas práticas.

(D'Amour *et al.*, 2005; Reeves *et al.*, 2017; Souza; Ely; Toassi, 2022)

O uso do *WhatsApp* como ferramenta de comunicação

O uso do aplicativo *WhatsApp* foi percebido como uma das principais ferramentas de comunicação entre os profissionais, sendo descrito como um recurso que facilita o contato, agiliza troca de informações e viabiliza a comunicação entre os membros da equipe, especialmente em contextos em que a interação presencial é mais difícil – em unidades maiores com mais equipes de Saúde da Família.

Apesar de seu potencial facilitador, a comunicação por meio de mensagens escritas é facilmente mal interpretada, sendo responsável por gerar conflitos e ruídos na comunicação. Além da má interpretação das mensagens, discussões iniciadas no ambiente virtual extrapolam os grupos de mensagens e repercutem no serviço, impactando no clima da equipe e nas relações interpessoais.



O conhecimento dos papéis profissionais foi identificado como elemento estruturante para a organização do trabalho colaborativo em equipe, contribuindo para o reconhecimento dos limites de cada área e para a construção de práticas colaborativas. As **reuniões de equipe**, as **visitas domiciliares** e as **interconsultas** foram identificadas como espaços potentes para a interação e para o trabalho colaborativo interprofissional. A inserção da eMulti foi percebida de forma positiva, como um recurso para o fortalecimento do trabalho em equipe e para a resolutividade do cuidado aos usuários-famílias-comunidade.

Por meio da discussão e do olhar compartilhado em equipe constitui-se o cuidado integrado e resolutivo em saúde, o que faz com que todos os profissionais sejam responsáveis pelo cuidado. Nesse processo de trabalho, a equipe busca compreender o paciente para além da queixa pontual, entendendo-o como um indivíduo inserido em um contexto social específico, levando em consideração aspectos emocionais, sociais, familiares e territoriais, favorecendo o trabalho conjunto e colaborativo da equipe. Considerando cada necessidade, a equipe pode decidir sobre flexibilizar fluxos, priorizar atendimentos e a articular com outros pontos da rede SUS e setores.

Entendendo CONCEITOS

Competências: tratam da aplicabilidade prática dos conhecimentos, habilidades e atitudes, aliando a uma prática reflexiva e ética.
(Franco *et al.*, 2014)

Competências colaborativas: referem-se à mobilização de conhecimentos-habilidades-atitudes necessárias ao trabalho em equipe, que contribuem para o desenvolvimento e o aprimoramento de práticas colaborativas. São organizadas em seis domínios:

- (1) cuidado/serviços centrados nas relações interpessoais e interprofissionais;
- (2) comunicação interprofissional;
- (3) compreensão dos papéis profissionais e negociação;
- (4) funcionamento da equipe;
- (5) resolução de conflitos; e
- (6) liderança colaborativa.

(Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2024)

O Agente Comunitário de Saúde no trabalho interprofissional

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) destaca-se na promoção do cuidado integral, atuando como elo entre a equipe e a comunidade. Seu conhecimento do território, da realidade local e das famílias contribui para a mediação das informações e para a construção de condutas mais adequadas à realidade dos usuários.

Os achados da pesquisa reforçam a importância de valorizar e fortalecer o papel do ACS como agente articulador do cuidado interprofissional na ESF.



Fonte: Elaborado pela autora, utilizando o software ChatGPT (OpenAI), 2026.

Competências colaborativas identificadas como essenciais ao trabalho em equipe com atuação interprofissional:

- Comunicação interprofissional
- Liderança interprofissional
- Resolução de conflitos
- Conhecimento dos papéis profissionais
- Atenção à saúde centrada nas necessidades dos usuários-famílias-comunidade



• Facilitadores do trabalho em equipe na ESF

Foram identificados como facilitadores do trabalho em equipe para uma atuação interprofissional e colaborativa:

- relações interpessoais positivas que permitem a construção de um ambiente de trabalho acolhedor, que favorece a interação e a colaboração entre os membros da equipe;
- trabalho pautado pela empatia, disponibilidade dos profissionais para o aprender/trabalhar com os colegas da equipe/usuários, resolutividade, respeito, comunicação, acolhimento e solidariedade;
- conhecimento técnico de cada profissional envolvido no cuidado;
- profissionais com objetivos comuns e voltados às necessidades dos usuários;
- ambiente de trabalho com estrutura física adequada – local seguro, limpo e organizado, com salas disponíveis para todos os profissionais e espaços apropriados para atividades coletivas, como reuniões de equipe e grupos;
- articulação da equipe com espaços intersetoriais para discussão e encaminhamento de casos complexos.

• Desafios do trabalho em equipe na ESF

Foram identificados como desafios do trabalho em equipe com atuação interprofissional e colaborativa:

- dificuldades de interação entre as profissões;
- falta de disponibilidade de determinados profissionais em atuar de forma integrada e colaborativa;

- tempo insuficiente das reuniões de equipe;
- ausência de participação de todos os profissionais da equipe nas reuniões;
- conflitos e ruídos na comunicação entre os profissionais;
- alta demanda de atendimentos e sobrecarga de trabalho;
- equipes incompletas na rotina do trabalho (afastamentos por atestado, férias);
- rotatividade de profissionais nas equipes.

• Estratégias para qualificar o trabalho em equipe na ESF

As estratégias para qualificar o trabalho em equipe na ESF, na percepção dos profissionais, envolveram aspectos estruturais, organizacionais e formativos. Destacaram-se como estratégias:

- ampliar o número de profissionais e equipes como possibilidade de ampliar o acesso e a oferta do cuidado na ESF. **Importante considerar que:** tal ampliação, de forma isolada e sem a garantia da educação permanente das equipes, não garante a efetivação do trabalho colaborativo, sendo necessário que esteja articulado à organização do processo de trabalho e à integração entre os profissionais, sob risco de manutenção de práticas fragmentadas;
- assegurar espaços de discussão coletiva entre todos os profissionais da equipe (garantir o espaço e a presença da equipe);
- ampliar o tempo de reuniões de equipe para a discussão dos casos mais complexos;
- investir em ações de educação permanente e capacitações que promovam a reflexão crítica interprofissional sobre as práticas de saúde, a problematização do cotidiano e a construção compartilhada com a equipe e com os usuários de novas formas de organização do cuidado.

Entendendo CONCEITOS

Educação Permanente em Saúde (EPS): consiste em um processo de aprendizagem integrado ao cotidiano do trabalho, baseado na reflexão crítica das práticas profissionais e voltado à transformação da organização dos serviços de saúde.
(Brasil, 2004; Ceccim, 2005)

A **EPS** configura-se como um espaço privilegiado de interação e aprendizagem no trabalho, com potencial para o desenvolvimento de competências colaborativas, especialmente relacionadas à comunicação interprofissional e ao reconhecimento dos papéis profissionais.
(Miorin *et al.*, 2020; Kanno *et al.*, 2023)

CONCLUSÃO

Este estudo produziu evidências qualitativas sobre o significado do trabalho em equipe na ESF a partir da experiência vivida de profissionais de diferentes núcleos, contribuindo para a compreensão de como o trabalho colaborativo interprofissional é percebido, organizado e desafiado no cotidiano da ESF. Os resultados evidenciaram que o trabalho em equipe é reconhecido pelos profissionais como condição indispensável para o cuidado integral e resolutivo, sendo construído continuamente a partir das relações, dos espaços coletivos e das condições oferecidas pelos serviços e pela gestão.

Seus achados apresentam potencial aplicabilidade para a qualificação do processo de trabalho em equipe e na organização dos serviços na ESF. Ao identificar facilitadores, desafios e estratégias de qualificação, a partir da perspectiva dos próprios profissionais, o estudo oferece subsídios para fortalecer o trabalho em equipe, contribuindo para a melhoria da atenção à saúde realizada aos usuários-famílias-comunidades nos territórios.

• Possibilidades de aplicação no contexto da ESF

Os resultados desse estudo indicam que o fortalecimento do trabalho em equipe na ESF está relacionado a organização dos processos de trabalho, à valorização da comunicação e à criação de condições que favoreçam a interação entre os profissionais. Nessa perspectiva, a qualificação das práticas colaborativas configura-se como uma estratégia central para a melhoria da qualidade da atenção à saúde da APS, desdobrando-se em recomendações para gestores e equipes de ESF.

Recomendações para gestores:

- assegurar condições estruturais para o trabalho em equipe: estrutura física adequada (local seguro, limpo e organizado, com salas disponíveis para todos os profissionais e espaços apropriados para atividades coletivas, como reuniões de equipe e grupos), equipes completas, tempo protegido para reuniões e participação de todos os profissionais nesses espaços;
- adotar modelos de gestão que valorizem o cuidado integral, pautado pelo vínculo, práticas humanizadas e resolutivas em saúde, superando metas exclusivamente produtivistas;
- apoiar a consolidação da eMulti como recurso integrado ao processo de trabalho da ESF, com definição de papéis e fluxos compartilhados;
- estruturar em conjunto com os profissionais/promover ações de EPS com foco na interprofissionalidade, no desenvolvimento da comunicação e na resolução de conflitos, com regularidade e intencionalidade;

- fortalecer práticas de cuidado centradas no usuário, com discussão interativa de casos em equipe e construção compartilhada de planos de cuidado;
- apoiar/promover a qualificação contínua de lideranças colaborativas e horizontais nas Unidades de Saúde, capazes de mediar conflitos, promover o diálogo e fortalecer o trabalho coletivo.

Recomendações para equipes de ESF:

- reconhecer os espaços coletivos (reuniões de equipe; visitas domiciliares; atividades educativas em grupos; interconsultas) como parte essencial do processo de trabalho em equipe e da equipe, e não como atividades secundárias à demanda assistencial;
- fortalecer a disponibilidade para o conhecimento dos diferentes papéis profissionais da equipe, como base para práticas colaborativas;
- investir na comunicação efetiva entre os profissionais, com atenção ao uso exclusivo e amplo de ferramentas digitais;
- promover o desenvolvimento da competência da comunicação interprofissional, incluindo a comunicação não violenta, como estratégia para qualificar o diálogo, a escuta, a resolução de conflitos, as relações interpessoais na equipe e o cuidado aos usuários-famílias;
- estimular/promover na equipe relações pautadas no respeito, na empatia e na responsabilidade compartilhada pelo cuidado dos usuários, independentemente de vínculos/afinidades pessoais.

DOCUMENTOS RECOMENDADOS

Marco para ação em educação interprofissional e prática colaborativa

Organização Mundial da Saúde, 2010

<https://www.who.int/publications/m/item/interprofessional-education-framework>



A National Interprofessional Competence Framework

Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2010

<https://chic.ca/wp-content/uploads/2015/07/CIHC-National-Interprofessional-Competence-Framework.pdf>



Educação interprofissional na atenção à saúde: melhorar a capacidade dos recursos humanos para alcançar a saúde universal

Organização Pan-Americana da Saúde, 2017

<https://paho.org/pt/publicacoes/educacao-interprofissional-na-atencao-a-saude-universal>



Interprofissionalidade e formação na saúde: onde estamos?

Rede Unida, 2017

<http://reunida.org.br/pt-br/educacao/interprofissionalidade-e-formacao-na-saude-onde-estamos>



Interprofessional Education Guidelines

Centre for the Advancement of Interprofessional Education, 2017

<https://www.cia-icpe.org/wp-content/uploads/2017/03/03-CIA-ICPE-Interprofessional-Education-Guidelines-2.pdf>



Competency Framework for Advancing Collaboration

Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2024

<https://chic.ca/wp-content/uploads/2024/06/CIHC-Competency-Framework.pdf>



Interprofessional health teams for integrated care

Pan American Health Organization, 2025

<https://paho.org/pt/publicacoes/interprofissionalidade-e-formacao-na-saude-universal>



Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais

Marshall B. Rosenberg, 2006

<https://www.mindtools.com/pages/new/STL/new06-2356-96.htm#6-2356-96.htm>



REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 198/GM**, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1832.pdf>
- CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE. **Competency Framework for Advancing Collaboration**. Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC), Vancouver, Apr. 2024.
<https://cihc-cpis.com/wp-content/uploads/2024/06/CIHC-Competency-Framework.pdf>
- CECCIM, R. B. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 161-177, set. 2004/fev. 2005.
<https://www.scielo.br/j/icse/a/jC4gdtHC8RPLWSW3WG8Nr5k/>
- COSTA, M. V. A Educação Interprofissional no contexto brasileiro: algumas reflexões. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 56, p. 197-198, 2016.
<https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0311>
- D'AMOUR, D. *et al.* The conceptual basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks. **Journal of Interprofessional Care**, Abingdon, v. 19, p. 116-131, 2005. Supl. 1.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13561820500082529>
- ELY, L. I.; TOASSI, R. F. C. Integração entre currículos na educação de profissionais da Saúde: a potência para educação interprofissional na graduação. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, p.1563-1575, 2018. Supl. 2.
<https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0658>
- ESCALDA, P.; PARREIRA, C. M. de S. F. Dimensões do trabalho interprofissional e práticas colaborativas desenvolvidas em uma unidade básica de saúde, por equipe de Saúde da Família. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 22, p. 1717-1727, 2018. Supl. 2.
<https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0818>
- FRANCO, R. S. *et al.* O conceito de competência: uma análise do discurso docente. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. 173-181, abr./jun. 2014.
<https://doi.org/10.1590/S0100-55022014000200003>
- FREIRE FILHO, J. R. *et al.* Educação Interprofissional nas políticas de reorientação da formação profissional em saúde no Brasil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. esp. 1, p. 86-96, ago. 2019.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042019000500086&tlng=pt

FRENK, J. *et al.* Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. **The Lancet**, London, v. 376, n. 9756, p. 1923-1958, 2010.

[https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(10\)61854-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(10)61854-5)

FRENK, J. *et al.* Challenges and opportunities for educating health professionals after the COVID-19 pandemic. **The Lancet**, London, v. 400, p. 1539-1556, 2022.

[https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(22\)02092-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)02092-x)

GARCIA, A. C. P. *et al.* O trabalho em equipe na estratégia saúde da família. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, Santa Cruz do Sul, v. 5, n. 1, p. 31-36, abr. 2015.

<https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/5314>

KANNO, N. de P. *et al.* A colaboração interprofissional na atenção primária à saúde na perspectiva da ciência da implementação. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, e00213322, 2023.

<https://doi.org/10.1590/0102-311XPT213322>

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da percepção**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MIORIN, J. D. *et al.* Colaboração interprofissional entre as equipes de saúde dos serviços de urgência e emergência: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 9, n. 2, e78922074, 2020.

<https://doi.org/10.33448/rsd-v9i2.2074>

OGATA, M. N. *et al.* Interfaces between permanent education and interprofessional education in health. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, e03733, 2021.

<https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020018903733>

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Marco para ação em educação interprofissional e prática colaborativa**. Genebra: OMS, 2010.

https://www.anamt.org.br/site/arquivos/meus_arquivos/arquivos/meu_arquivo/m5086a98b7c2b9.pdf

PEDUZZI, M. *et al.* Educação interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 4, p. 977-983, 2013.

<https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000400029>

PEDUZZI, M. O SUS é interprofissional. **Interface (Botucatu, Online)**, Botucatu, v. 20, n. 56, p. 199-201, jan. 2016.

<https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0383>

PEDUZZI, M. *et al.* Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 18, e0024678, 2020.

<https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00246>

REEVES, S. *et al.* Interprofessional education: effects on professional practice and healthcare outcomes. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], issue 3, art. n. CD002213, p. 1-41, 2013.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD002213.pub3>

REEVES, S. *et al.* Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, [s. l.], issue 6, art. n. CD000072, p. 1-38, 2017.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6481564/pdf/CD000072.pdf>

SOUZA, R. S. de; ELY, L. I.; TOASSI, R. F. C. Educação interprofissional em saúde: aprendizados de uma experiência inovadora de integração entre pessoas, currículos e profissões. **Pro-Posições**, [s. l.], v. 33, e20200011, maio 2022.

<https://doi.org/10.1590/1980-6248-2020-0011>

TOASSI, R. F. C. *et al.* The role of interprofessional education in dentistry training: understanding the perception of Brazilian dental students. **European Journal of Dental Education**, [s. l.], v. 30, n. 2, p. 253-261, 2026.

<https://doi.org/10.1111/eje.13112>